

Bunga Rampai

KEPERAWATAN KOMUNITAS DALAM MENGHADAPI MASALAH KESEHATAN MASYARAKAT



Septi Ardianty
Lindawati Simorangkir
Faisal Ibnu

Editor: Putri Ilham Sari

BUNGA RAMPAI: KEPERAWATAN KOMUNITAS DALAM MENGHADAPI MASALAH KESEHATAN MASYARAKAT

Penulis:

Septi Ardianty, S.Kep., Ns., M.Kep.
Lindawati Simorangkir, S.Kep., Ns., M.Kes.
Dr. Faisal Ibnu, S.Pd., S.Kep., Ns., M.Kes.

Editor:

dr. Putri Ilham Sari, MARS.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Bunga Rampai: Keperawatan Komunitas dalam Menghadapi Masalah Kesehatan Masyarakat

Penulis: Septi Ardianty, S.Kep., Ns., M.Kep.
Lindawati Simorangkir, S.Kep., Ns., M.Kes.
Dr. Faisal Ibnu, S.Pd., S.Kep., Ns., M.Kes.

Editor: dr. Putri Ilham Sari, MARS.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Achmad Faisal

ISBN: 978-634-7219-27-5

Cetakan Pertama: Mei, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram : @bimbel.optimal



PENERBIT:

Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022

Prakata

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku “Keperawatan Komunitas dalam Menghadapi Masalah Kesehatan Masyarakat” ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir dengan melihat berbagai tantangan kesehatan yang dihadapi masyarakat, mulai dari permasalahan kesehatan remaja hingga meningkatnya kasus penyakit tidak menular di berbagai lapisan komunitas.

Disusun melalui perpaduan antara pengalaman lapangan, kajian literatur, dan tinjauan kebijakan yang relevan, buku ini dirancang untuk menjadi referensi sekaligus panduan praktis. Sasaran utamanya adalah mahasiswa, tenaga kesehatan, serta masyarakat umum yang berkecimpung dalam pengembangan dan pelaksanaan program kesehatan berbasis komunitas. Dengan pendekatan yang aplikatif, buku ini diharapkan dapat mendorong peningkatan literasi kesehatan dan memperkuat upaya bersama dalam membangun masyarakat yang lebih sehat dan mandiri.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan buku ini. Semoga buku ini memberikan manfaat yang luas dan menjadi salah satu kontribusi positif dalam pengembangan pelayanan kesehatan masyarakat.

Penulis

Daftar Isi

Prakata.....	iv
Daftar Isi	v

BAB 1 Keperawatan Komunitas Dalam Manajemen Kesehatan Remaja	
Septi Ardianty, S.Kep., Ns., M.Kep.	1
A. Definisi Remaja.....	1
1. Pendahuluan	1
2. Perilaku Kesehatan Remaja	3
3. Keterbatasan Untuk Mendapatkan Informasi Tentang Kesehatan Remaja	4
4. Media Sosial Sebagai Wadah Menggali Informasi Kesehatan.....	5
B. Karakteristik Remaja.....	6
1. Klasifikasi Remaja	6
2. Perubahan Psikososial Remaja	6
3. Permasalahan Remaja	9
4. Perkembang Kognitif Pada Remaja	10
5. Perubahan Sosial dan Emosional.....	11
C. Peran Keluarga Dalam Kesehatan Remaja.....	13
1. Terdapat 8 Tahapan Perkembangan Keluarga	13
2. Peran Orang Tua Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja	15

3. Hal-Hal yang Harus Diberikan Oleh Orang Tua	18
D. Masalah – Masalah Kesehatan Pada Remaja	20
1. Masalah Kesehatan Sistem Reproduksi Pada Remaja.....	20
2. Masalah Status Gizi Remaja	23
3. Kehamilan Usia Remaja	26
4. Perilaku Merokok	27
E. Upaya Pencegahan Masalah Kesehatan Pada Remaja.....	29
1. Program Kesehatan Remaja.....	29
2. Pendidikan Kesehatan	30
3. Pola Asuh Yang Baik	31
Referensi.....	34
Glosarium.....	36

BAB 2 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) di Komunitas Lindawati Simorangkir, S.Kep,. Ns,.M.Kes.....	37
A. Pendahuluan	37
B. Konsep Penyakit Tidak Menular.....	38
1. Proses Terjadinya PTM.....	38
2. Ciri - Ciri Penyakit Tidak Menular	39
3. Jenis Penyakit Tidak Menular	41
C. Pencegahan Penyakit Tidak Menular	58
D. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	59
E. Kesimpulan	64
Referensi.....	65
Glosarium.....	68

BAB 3 Peran Keperawatan Komunitas Dalam Pemulihan Kesehatan Pasca Bencana	
Dr. Faisal Ibnu, S.Pd., S.Kep.Ns., M.Kes.....	71
A. Pendahuluan	71
B. Manajemen Bencana	72
1. Tahap Pra Bencana	74
2. Tahap Tanggap Darurat (Intra Bencana)	76
3. Tahap Pasca Bencana	77
C. Pemulihan Kesehatan	78
D. Peran Keperawatan Komunitas dalam Pemulihan Kesehatan	79
1. Perawat Komunitas.....	79
2. Tugas dan Peran Perawat Komunitas	80
3. Peran dan Tugas Perawat Komunitas Dalam Penanggulangan Bencana	88
4. Strategi Pemulihan Pasca Bencana	93
E. Kesimpulan	97
Referensi.....	100
Glosarium.....	104
Profil Penulis.....	105

BAB 1

Keperawatan Komunitas Dalam Manajemen Kesehatan Remaja

Septi Ardianty, S.Kep., Ns., M.Kep.

A. Definisi Remaja

1. Pendahuluan

Indonesia saat ini berada pada masa “bonus demografi”, yang mana jumlah usia produktif penduduk lebih besar dibandingkan dengan kategori usia lainnya. Hampir 70,7% dari jumlah total penduduk Indonesia berada pada usia produktif, yaitu sebanyak 185,34 jiwa dan 16, 81% adalah remaja. Kondisi ini tentunya menjadi sebuah tantangan yang harus disikapi dengan tepat agar “bonus demografi” ini agar bisa menjadi peluang bagi negara untuk bisa lebih berkembang atau bahkan lebih maju. Agar dapat menjadi produktif kondisi masyarakat Indonesia harus optimal dan sehat.

Masa remaja merupakan masa transisi antara usia anak dengan usia dewasa. Mereka berada pada jenjang tengah, tidak disebut anak kecil lagi namun belum dapat disebut orang dewasa. Intinya sedang dalam masa transisi dari usia anak hingga dewasa. Menurut *World Health Organization* remaja merupakan manusia yang berusia dari 10 sampai 19 tahun. Remaja merupakan penduduk dengan usia 10 – 18 tahun (Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 tahun 2014). Adapun Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) mengkategorikan remaja sebagai penduduk dengan umur 10 – 24 tahun dan belum pernah menikah. Masa remaja diwarnai oleh pertumbuhan, perubahan, munculnya berbagai kesempatan, dan seringkali menghadapi risiko-risiko bagi kesehatan. Oleh karena itu, kebutuhan akan peningkatan pelayanan kesehatan dan sosial terhadap remaja semakin menjadi perhatian di seluruh penjuru dunia, Oleh karena itu para remaja perlu diberikan pengetahuan yang lengkap tentang kesehatan, agar mereka memiliki wawasan komprehensif tentang perawatan kesehatan dan terhindar dari penyakit menular. Selain itu melalui penyuluhan ini diharapkan para remaja memiliki keterampilan untuk mempraktikkan cara merawat Kesehatan diri secara intensif dan berkelanjutan.

Upaya pemeliharaan kesehatan remaja untuk mempersiapkan menjadi orang dewasa yang sehat fisik dan mental serta produktif baik sosial maupun ekonomi termasuk untuk reproduksi remaja dilakukan agar terbebas dari berbagai gangguan kesehatan yang dapat menghambat kemampuan menjalani kehidupan reproduksi secara sehat. Undang-undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 pasal 131 Ayat 2 menyebutkan bahwa upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan dan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun. Berdasarkan Undang-undang Kesehatan no.36 tahun 2009 pasal 136 dan 137, pemerintah berkewajiban menjamin agar remaja dapat memperoleh reedukasi, informasi dan layanan mengenai kesehatan remaja agar mampu hidup sehat dan bertanggung jawab (Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2009). Upaya pemerintah dalam pemeliharaan kesehatan remaja perlu didukung dengan peran serta masyarakat yang baik.

2. Perilaku Kesehatan Remaja

Beberapa faktor dapat menjadi indikator derajat kesehatan yaitu kondisi ekonomi, status pekerjaan, tingkat pendidikan, usia, dan literasi kesehatan. Literasi kesehatan adalah kondisi sejauh apa seseorang memiliki kapasitas untuk memperoleh, berproses, dan memahami kesehatan-kesehatan dasar dan layanan

yang diperlukan untuk membuat suatu keputusan yang tepat. Kesehatan dasar ini dapat ditinjau dari perilaku kesehatan yang dimunculkan oleh seseorang yang menggambarkan pengetahuan dan sikapnya.

Kesehatan menunjukkan bahwa hal yang berpotensi mempengaruhi perilaku kesehatan pada remaja. Perilaku kesehatan remaja mencakup konsumsi minuman beralkohol atau bersoda dan obat-obatan terlarang, diet sehat, sanitasi atau hygiene personal atau sekolah dan kesehatan reproduksi, kesehatan mental remaja, kesehatan reproduksi, aktivitas fisik, dan merokok. Gambaran perilaku kesehatan saat remaja menggambarkan perilaku kesehatan manusia pada saat dewasa nanti, hal ini akan meningkatkan resiko terjadinya penyakit.

3. Keterbatasan Untuk Mendapatkan Informasi Tentang Kesehatan Remaja

Kemampuan literasi kesehatan digambarkan dengan kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, dan memahami informasi. Seseorang yang kesulitan dalam membaca juga akan kesulitan dalam memahami sebuah informasi [4]. Pengaruh dari rendahnya tingkat literasi ini (membaca menulis dan memahami) atau keaksaraan menjadi tantangan bagi dunia kesehatan, hal ini disebabkan sangat banyak informasi kesehatan yang disajikan dengan keaksaraan. Sehingga kondisi ini

menuntut penyedia layanan kesehatan berimprovisasi dalam membuat media informasi agar dapat diterima baik oleh masyarakat.

Gambaran terlaksananya literasi kesehatan, sangat erat kaitannya dengan usaha untuk memperkuat masyarakat untuk menjaga kesehatannya secara individu, kelompok, dan komunitas dan membuat kelompok masyarakat untuk menghindari dampak yang buruk terhadap kesehatannya [5]. Remaja adalah masa transisi menuju dewasa, dalam perkembangannya seorang remaja membutuhkan orang tua atau bahkan peran teman sebaya yang dijadikan role model dalam tugas perkembangannya.

4. Media Sosial Sebagai Wadah Menggali Informasi Kesehatan

Media informasi sangat banyak dikembangkan dalam edukasi kesehatan. Pengembangan media ini beragam dimulai dari visualisasi sederhana sampai dengan media audiovisual yang kompleks. Pemilihan media edukasi yang sesuai dengan remaja juga menjadi salah satu indikator keberhasilan literasi kesehatan [4]. Media edukasi berupa booklet bergambar menjadi salah satu media yang dipakai dalam kegiatan pengabdian ini, hal ini digunakan agar informasi terkait perilaku kesehatan dapat diterima dengan baik oleh para remaja.

B. Karakteristik Remaja

1. Klasifikasi Remaja

Menurut batasan umur Departemen Kesehatan Republik Indonesia remaja dibagi menjadi 2, yaitu masa remaja awal (12-16) dan masa remaja akhir (17-25).”
klasifikasi remaja berdasarkan umur beserta karakteristiknya sebagai berikut:

- a. Masa remaja awal (10-12 tahun)
- b. Masa remaja pertengahan (13-16 tahun)
- c. Masa remaja akhir (17-21 tahun)

Klasifikasi remaja pada umumnya didasarkan pada perubahan psikososial pada remaja. Perubahan fisik yang cepat dan terjadi berkelanjutan pada remaja menyebabkan para remaja sadar dan lebih sensitif terhadap bentuk tubuhnya dan mencoba membandingkan dengan teman-teman sebaya. Jika perubahan tidak berlangsung secara lancar maka berpengaruh terhadap perkembangan psikis dan emosi anak, bahkan terkadang timbul ansietas, terutama pada anak perempuan bila tidak dipersiapkan untuk menghadapinya. Sebaliknya pada orangtua keadaan ini dapat menimbulkan konflik bila proses anak menjadi dewasa ini tidak dipahami dengan baik.

2. Perubahan Psikososial Remaja

Perubahan psikososial pada remaja dibagi dalam tiga tahap yaitu remaja awal (early adolescent), pertengahan (middle adolescent), dan akhir (late adolescent).

Periode pertama disebut remaja awal atau early adolescent, terjadi pada usia-usia 12-14 tahun. Pada masa remaja awal anak-anak terpapar pada perubahan tubuh yang cepat, adanya akseerasi pertumbuhan, dan perubahan komposisi tubuh disertai awal pertumbuhan seks sekunder. Karakteristik periode remaja awal ditandai oleh terjadinya perubahan-perubahan psikologis seperti:

- a. Krisis identitas
- b. Jiwa yang labil
- c. Meningkatnya kemampuan verbal untuk ekspresi diri
- d. Pentingnya teman dekat/sahabat
- e. Bekurangnya rasa hormat terhadap orang tua, kadang-kadang berlaku kasar
- f. Menunjukkan kesalahan orangtua
- g. Mencari orang lain yang disayang selain orangtua
- h. Kecenderungan untuk berlaku kekanak-kanakan

Terdapatnya pengaruh teman sebaya (peer group) terhadap hobi pada fase remaja awal mereka hanya tertarik pada keadaan sekarang, bukan masa depan, sedangkan secara seksual mulai timbul rasa malu, ketertarikan terhadap lawan jenis tetapi masih bermain berkelompok dan mulai bereksperimen dengan tubuh seperti masturbasi. Selanjutnya pada periode remaja awal, anak juga mulai melakukan eksperimen dengan rokok, alkohol, atau narkoba. Peran peer group sangat

dominan, mereka berusaha membentuk kelompok, bertingkah laku sama, berpenampilan sama, mempunyai bahasa dan kode atau isyarat yang sama. Periode selanjutnya adalah middle adolescent terjadi antara usia 15-17 tahun, yang ditandai dengan terjadinya perubahan-perubahan sebagai berikut:

- Mengeluh orangtua terlalu ikut campur dalam kehidupannya
- Sangat memperhatikan penampilan
- Berusaha untuk mendapat teman baru
- Tidak atau kurang menghargai pendapat orangtua
- Sering sedih/*moody*
- Mulai menulis buku harian
- Sangat memperhatikan kelompok main secara selektif dan kompetitif
- Mulai mengalami periode sedih karena ingin lepas dari orangtua

Pada periode middle adolescent mulai tertarik akan intelektualitas dan karir. Secara seksual sangat memperhatikan penampilan, mulai mempunyai dan sering berganti-ganti pacar. Sangat perhatian terhadap lawan jenis. Sudah mulai mempunyai konsep model dan mulai konsisten terhadap cita-cita. Periode late adolescent dimulai pada usia 18 tahun ditandai oleh tercapainya maturitas fisik secara sempurna.

Perubahan psikososial yang ditemui antara lain:

- Identitas diri menjadi lebih kuat
- Mampu memikirkan ide
- Mampu mengekspresikan perasaan dengan kata-kata
- Lebih menghargai orang lain
- Lebih konsisten terhadap minatnya
- Bangga dengan hasil yang dicapai
- Selera humor lebih berkembang
- Emosi lebih stabil

Pada fase remaja akhir lebih memperhatikan masa depan, termasuk peran yang diinginkan nantinya. Mulai serius dalam berhubungan dengan lawan jenis, dan mulai dapat menerima tradisi dan kebiasaan lingkungan.

3. Permasalahan Remaja

Masa remaja adalah peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek/fungsi untuk memasuki masa dewasa. Masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria. (Rumini dan Sundari, 2004: 53). Masa remaja seringkali menjadi masa dimana remaja melakukan perilaku-perilaku seksual. Perilaku seksual dapat didefinisikan sebagai bentuk perilaku yang didorong oleh hasrat seksual baik dengan lawan

jenis maupun sejenis. Menurut Simkin, perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis. Bentuk tingkah laku ini beraneka ragam mulai dari perasaan tertarik hingga tingkah laku berkencan, bercumbu dan bersenggama. (Amrillah, 2006: 10). Beberapa perilaku seksual remaja menyebabkan banyak timbulnya permasalahan. Permasalahan tersebut biasanya diawali dengan perilaku seksual pranikah hingga terjadi kehamilan dan aborsi.

4. Perkembang Kognitif Pada Remaja

Remaja cenderung berpikir abstrak dan suka memberikan kritik, selain itu rasa ingin tahu remaja terhadap hal-hal baru cenderung meningkat. Fenomena yang ada sering kali remaja mengeluh depresi, stress, dan frustasi menghadapi tugas-tugas dan tuntutan belajar dari sekolah maupun perguruan tinggi. Sehingga biasanya remaja mengatasi rasa stress tersebut dengan merokok, meminum minuman keras, bahkan penggunaan obat-obat terlarang serta. Gejala perilaku seksual pranikah pada remaja laki-laki dan perempuan usia 10-24 tahun sudah terjadi. Walaupun angkanya masih di bawah 5 persen, kejadian ini seharusnya dapat dicegah dengan memberikan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi sejak usia masih muda (Balitbangkes Kemenkes RI, 2010).

Fenomena di masyarakat, remaja juga cenderung memiliki pola hidup yang tidak sehat seperti kebiasaan makan junk food dan begadang. Pola hidup yang salah pada remaja dapat meningkatkan resiko timbulnya banyak penyakit hipertensi, kanker paru, kanker hati, gagal ginjal, AIDS dan bahkan kematian.

5. Perubahan Sosial dan Emosional

Remaja cenderung lebih sensitif dengan keadaan sekitarnya, hal-hal yang dapat mempengaruhi emosi remaja bermacam-macam salah satunya adalah keluarga dan lingkungan. Hal ini akan mempengaruhi sikap dan tindakan remaja pada suatu kejadian atau hal-hal di sekitarnya. Seorang remaja berada pada batas peralihan kehidupan anak dan dewasa. Tubuhnya kelihatan sudah “dewasa” akan tetapi bila diperlakukan seperti orang dewasa ia akan gagal menunjukkan kedewasaannya.

Pengalaman mengenai alam dewasa masih belum banyak karena itu sering terlihat pada mereka berbagai hal seperti (Mayawati, 2011; Ulina'mah, 2014):

a. Kegelisahan

Keadaan yang tidak tenang menguasai diri si remaja, mereka mempunyai banyak macam keinginan yang tidak selalu dapat dipenuhi, disatu pihak ingin mencari pengalaman, karena diperlukan untuk menambah pengetahuan dan keluwesan dalam

tingkah laku. Akhirnya mereka hanya dikuasai oleh perasaan gelisah karena keinginan-keinginannya yang tidak tersalurkan (Mayawati, 2011; Ulina'mah, 2014)

b. Pertentangan

Pertentangan-pertentangan yang terjadi di dalam diri mereka juga menimbulkan kebingungan baik bagi diri mereka sendiri maupun orang lain. Pada umumnya timbul perselisihan dan pertentangan pendapat antara si remaja dan orang tua. Pertentangan ini menyebabkan timbulnya keinginan yang hebat untuk melepaskan diri dari orang tua (Mayawati, 2011; Ulina'mah, 2014).

c. Berkeinginan besar mencoba segala hal yang belum diketahuinya

Mereka ingin mengetahui macam-macam hal melalui usaha-usaha yang dilakukan dalam berbagai bidang (Mayawati, 2011; Ulina'mah, 2014).

d. Keinginan sering pula diarahkan pada diri sendiri maupun terhadap orang lain

Keinginan mencoba ini tidak hanya dalam bidang penggunaan obat-obatan akan tetapi meliputi segala hal. Akhirnya penjelajahan ketubuh bisa menyebabkan pengalaman dengan akibat yang tidak selalu menyenangkan, misalnya kehamilan yang menghentikan karir, prestasi, dan sekolah (Mayawati, 2011; Ulina'mah, 2014).

- e. Penyaluran yang bermanfaat dapat menghasilkan penemuan alat-alat baru atau modifikasi
Khayalan dan fantasi, pada remaja putra banyak berkisar mengenai prestasi dan tangga karier. Khayalan dan fantasi tidak selalu negative, karena dipihak lain dianggap sebagai pelarian dari situasi dan suasana yang tidak memuaskan remaja (Mayawati, 2011; Ulina'mah, 2014).
- f. Aktivitas berkelompok
Antara keinginan yang satu dengan keinginan yang lain sering timbul tantangan, hal ini jelas tidak dapat dibiarkan sehingga perlu usaha mencari jalan keluar dari keadaan seperti ini.

C. Peran Keluarga Dalam Kesehatan Remaja

1. Terdapat 8 Tahapan Perkembangan Keluarga

Tahap perkembangan dalam keluarga dibagi menjadi delapan tahap antara lain, keluarga dengan pasangan baru. Keluarga dengan tahap ini baru saja membentuk tali pernikahan yang memuaskan bagi satu sama lain. Tahap perkembangan yang kedua, tahap keluarga dengan kelahiran anak pertama *Childbearing Family*. Merupakan tahap perkembangan keluarga yang dimulai dari kehamilan sampai kelahiran anak pertama dan berlanjut sampai anak berusia 30 bulan. Tahap perkembangan yang ketiga, keluarga dengan anak pra-sekolah. Tahap ini dimulai ketika anak berumur 2,5 tahun dan diakhiri ketika anak berumur 5 tahun. Tahap

yang keempat, keluarga dengan anak sekolah. Tahap ini dimulai ketika anak memasuki usia sekolah atau usia 5 sampai 13 tahun.

Tahap perkembangan yang kelima, keluarga dengan anak remaja. Dimulai ketika anak pertama berusia 13 tahun. Tahap yang keenam, keluarga dewasa muda. Pada tahap ini ditandai dengan perginya anak pertama dari lingkungan rumah dan berakhir dengan anak yang terakhir juga meninggalkan rumah. Tahap yang ketujuh, keluarga paruh baya. Merupakan tahap masa pertengahan bagi orang tua, tahap ini dimulai ketika anak terakhir meninggalkan rumah dan berakhir dengan pensiunan orang tua. Dan tahap perkembangan keluarga yang terakhir adalah keluarga dengan lansia. Tahap ini dimulai dengan pensiunan salah satu atau kedua pasang dan berlanjut sampai kehilangan salah satu pasangan.

Pada tahap perkembangan keluarga remaja sendiri memiliki tugas yaitu menyeimbangkan kebebasan dengan tanggung jawab ketika remaja menjadi dewasa dan mandiri, memfokuskan kembali hubungan perkawinan, berkomunikasi secara terbuka antara orangtua dan anak-anak, memberikan perhatian, memberikan kebebasan dalam batasan tanggung jawab, mempertahankan komunikasi terbuka dua arah.

2. Peran Orang Tua Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja merupakan salah satu dari sekian banyak masalah sosial yang semakin merebak dewasa ini. Pasalnya di zaman globalisasi ini, intensitas kenakalan remaja terus meningkat. Kasus kenakalan remaja saat ini sudah mengarah kepada perbuatan yang besinggungan dengan perbuatan kriminal dan pelanggaran hukum. Belakangan ini banyak kejadian sekitar kita seperti halnya kasus seks bebas atau free sex , pemerkosaan, penyalahgunaan narkoba, minuman keras dan lain sebagainya. Arus kemerosotan moral yang semakin melanda di kalangan remaja. Padahal sejatinya mereka adalah generasi penerus bangsa. hal ini disayangkan mengingat para generasi muda kita saat ini lebih terkenal dengan sebutan remaja nakal atau anak labil yang sedang mencari jati dirinya. Akan tetapi dalam proses mereka cenderung ingin melakukan hal-hal yang menyimpang daripada menyibukkan diri dengan kegiatan positif dan rajin belajar. Kenakalan remaja memang bukan merupakan masalah baru bagi masyarakat Indonesia.

Sejak dulu, kenakalan remaja memang sudah ada, namun dalam bentuk yang sama sekali berbeda dengan kenakalan remaja zaman sekarang atau zaman now. Kenakalan remaja saat ini tidak berbentuk bolos sekolah, mencuri kecil-kecilan, tidak patuh pada orang

tua, tetapi mengarah pada tindakan kriminal, seperti perkelahian massal antar pelajar (tawuran) yang menyebabkan kematian, seks bebas, pemerkosaan, pembunuhan, penyalahgunaan narkoba dan lain-lain. Dalam media seringkali diberitakan tentang perkelahian pelajar, penyebab penyalahgunaan narkoba, pemakaian obat bius, minuman keras, penjangbretan yang dilakukan oleh anak yang berusia belasan tahun, meningkatnya kasus-kasus kehamilan di kalangan remaja putri, dan lain-lain. Hal tersebut sangatlah wajar dan memang selalu terjadi di seluruh belahan dunia, namun sangat salah kalau membiarkan hal tersebut terjadi. Secara psikologi, remaja dapat dikatakan sebagai masa peralihan dari anak-anak ke dewasa. Seorang remaja sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai anak-anak, namun mereka masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Mereka sedang mencari pola hidup yang paling sesuai dengan keadaanya dan ini juga sering dilakukan melalui metode coba-coba walaupun melalui banyak kesalahan yang dilakukannya. Masa pencarian jati diri yang disertai keinginan yang tinggi untuk menemukan pedoman hidup seringkali menimbulkan penyimpangan yang dilakukan oleh remaja tersebut.

Pada masa ini disebut juga masa labil, karena emosi yang cenderung mudah berubah membuat para remaja bersikap tidak ingin diatur dan cenderung ingin

memberontak saat merasa tekanan yang berlebih. Tekanan untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan membuat remaja memberontak dan melakukan kenakalan yang lain. Remaja sangatlah mudah terpengaruh oleh lingkungan luar dan dalam. Pengaruh dari lingkungan luar kadang perlu dicegah, supaya tidak begitu besar perangsangannya terutama yang bersifat negatif. Demikian pula lingkungan dalam diri yang dapat memengaruhi munculnya perilaku yang tidak bisa ditoleransi oleh umum, oleh masyarakat harus dikendalikan dan dicegah permunculannya.⁵ Sejatinya, pendidikan merupakan sarana yang dapat mengontrol perilaku dan pergaulan si anak agar tidak terjerumus ke dalam perilaku yang menyimpang. Tidak ada lembaga yang bebas dari kontrol eksternal, baik sekolah yang didirikan pemerintah maupun swasta. Kontrol langsung di sekolah bersumber pada kepala sekolah dan guru. Merekalah yang menentukan kelakuan yang bagaimana yang diharapkan dari peserta didik.

Salah satu pengendali kenakalan remaja yang paling berpengaruh secara teoritis adalah keluarga. Keberadaan keluarga mampu menjaga dan menyelamatkan individu dan kelompok dari perilaku menyimpang, keluarga cerminan kehidupan seseorang. Artinya, kehidupan keluarga yang harmonis dapat dilihat dari tingkah laku dan pola hubungan dengan

lingkungan sekitar. Jika orangtua memberikan waktu luang untuk membina dan mengarahkan anaknya. Anak akan menjadi suri tauladan bagi dirinya sendiri dan bahkan orang lain. Anak akan hidup teratur dan tidak berbuat yang macam-macam. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan keengganan orangtua dalam membina anaknya. Kurangnya perhatian terhadap anak dalam menanggulangi kenakalan remaja, orang tua juga sibuk dalam mencari nafkah dengan bekerja di luar rumah. Selain itu orang tua juga sibuk dengan aktivitas sendiri seperti main gadget dan kurang mengawasi anak remajanya yang dianggap mampu mengontrol diri namun sebenarnya masih membutuhkan bimbingan, di sinilah peran orang tua dalam penanggulangan kenakalan remaja, karena kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya sebagian besar anak melakukan kenakalan. Maka dalam hal ini orang tua mempunyai peran mengarahkan atau memberikan bimbingan kepada anak untuk berada pada perilaku yang tidak menyimpang.

3. Hal-Hal yang Harus Diberikan Oleh Orang Tua

- a. Memberikan penjelasan mengenai hal yang baik dan juga buruk bagi anak Hal yang terpenting yang harus dilakukan oleh orang tua adalah memberikan pemahaman mengenai hal yang tidak boleh dilakukan oleh anak. Ada baiknya, orangtua memberikan penjelasan dengan bahasa yang mudah

dimengerti, sehingga anak-anak tidak bingung, dan paham akan penjelasan tersebut.

- b. Pendidikan orang tua yang keras juga akan menyebabkan anaknya menjadi keras. Pola pendidikan dan juga pola asuh yang keras, akan menyebabkan anak-anak menjadi disiplin, namun akan meningkatkan kemungkinan seorang anak untuk tidak nyaman. Menggunakan pola pendidikan yang keras dan tegas boleh saja, tetapi ada baiknya disandingkan dengan pola asuh yang lebih permisif, sehingga anak-anak tidak akan merasa takut dengan orangtuanya sendiri, namun tetap menghargai orangtuanya.
- c. Edukatif: keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya dimana orang tua memiliki perang yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan rohani dalam dimensi kognisi, afektif maupun skill, dengan yujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan profesional. Fungsi edukatif ini merupakan bentuk penjagaan hak dasar manusia dalam memelihara dan mengembangkan potensi akalnya. Sejak dulu merupakan institusi pendidikan dalam keluarga merupakan satu-satunya institusi untuk mempersiapkan anak agar dapat secara sosial di masyarakat, sekarang pun keluarga dikenal sebagai lingkungan pendidikan yang pertama dan

utama dalam mengembangkan dasar kepribadian anak.

D. Masalah – Masalah Kesehatan Pada Remaja

1. Masalah Kesehatan Sistem Reproduksi Pada Remaja

Menurut WHO (2007) Sehat adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan, dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya. Menurut BKKBN (2001), definisi kesehatan reproduksi adalah kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan. Menurut WHO kesehatan reproduksi adalah :Suatu keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial yang utuh bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi dan prosesnya.

Menurut Depkes RI (2000) kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sehat secara menyeluruh mencakup fisik, mental dan kehidupan sosial yang berkaitan dengan alat, fungsi serta proses reproduksi yang pemikiran kesehatan reproduksi bukannya kondisi yang bebas dari penyakit melainkan bagaimana seseorang dapat memiliki kehidupan seksual yang aman dan

memuaskan sebelum dan sesudah menikah. Kesehatan reproduksi diartikan sebagai suatu kondisi yang menjamin bahwa fungsi reproduksi, khususnya proses reproduksi, dapat berlangsung dalam keadaan sejahtera fisik, mental, maupun sosial dan bukan saja terbebas dari penyakit atau gangguan fungsi alat reproduksi. Setiap anak termasuk remaja memiliki hak untuk memperoleh system reproduksi yang sehat. Menurut Hurlock adolescence yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolescence mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional sosial dan fisik. Remaja memiliki hak untuk mendapat informasi mengenai Kesehatan. Indonesia merupakan negara yang ikut mensertifikasi Konversi Hak Anak (KHA) pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990. Ratifikasi ini mengisyaratkan bahwa negara Indonesia terikat secara yuridis dan politis atas segala ketentuan yang ada di dalam konvensi tersebut.

Secara rinci Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) di Kairo 1994, menetapkan adanya 11 hak hak reproduksi untuk anak remaja yaitu:

- 1) Hak mendapatkan informasi dan pendidikan.
- 2) Hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi.
- 3) Hak untuk kebebasan berfikir tentang kesehatan reproduksi.

- 4) Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk termasuk
- 5) perlindungan dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan dan pelecehan seksual.
- 6) Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk termasuk perlindungan dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan dan pelecehan seksual.
- 7) Hak mendapatkan manfaat dari Kemajuan Ilmu Pengetahuan yang terkait dengan kesehatan reproduksi. 7. Hak untuk menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran.
- 8) Hak untuk hidup (hak untuk dilindungi dari kematian karena kehamilan dan proses melahirkan).
- 9) Hak atas kebebasan dan keamanan berkaitan dengan kehidupan reproduksi.
- 10) Hak atas kerahasiaan pribadi dengan kehidupan reproduksinya. 1
- 11) Hak membangun dan merencanakan keluarga.
- 12) Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi.
- 13) Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam kehidupan berkeluarga dan kehidupan reproduksi.

Merawat Kesehatan Sistem Reproduksi adalah hal yang sangat penting terutama bagi para remaja. Remaja putri atau dewasa muda berada pada usia pra nikah, yang merupakan masa persiapan bagi kesehatan reproduksi yang baik. Cara merawat kesehatan reproduksi agar lebih sehat yaitu dengan menerapkan pola makan sehat, olahraga serta dengan mengkonsumsi vitamin dan suplemen

2. Masalah Status Gizi Remaja

Pada fase remaja merupakan fase yang banyak mengalami perubahan gaya hidup dan kebiasaan makan. Adanya faktor lingkungan menyebabkan perbedaan preferensi makan, khususnya bagi anak perempuan. Sebagian besar remaja yang mengikuti kegiatan edukasi ini berjenis kelamin perempuan. Komposisi tubuh berdasarkan perbedaan jenis kelamin, kriteria persen lemak tubuh pada perempuan lebih tinggi karena perbedaan hormon dan juga perempuan dipersiapkan menjadi calon ibu. Sehingga pemberian edukasi gizi yang paling cepat berpengaruh terhadap perubahan sikap dan perilaku adalah saat masa remaja. Salah satu poin dalam edukasi gizi ini mengetahui porsi makan melalui tumpeng gizi seimbang dan piring makanku.

Perlunya setiap remaja mengetahui karakteristik, inovasi dan keberagaman dari menu gizi seimbang agar yang dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan karena perkembangan zaman yang sangat dinamis berdampak pada perubahan pola konsumsi makan. Pada masa remaja ini keingintahuan dari berbagai jenis makanan dan minuman yang trend ingin dicoba untuk dikonsumsi. Harapannya setelah pemberian edukasi ini para remaja di Karang Taruna RT 09 lebih kritis dan paham jenis bahan makanan yang baik untuk kesehatan berdasarkan komposisi bahan makanan.

Penilaian status gizi merupakan kondisi keseimbangan antara asupan dan kebutuhan zat gizi yang diperlukan tubuh untuk tumbuh kembang terutama untuk anak sampai usia dewasa, aktifitas, pemeliharaan kesehatan, penyembuhan bagi mereka yang menderita sakit dan proses biologis lainnya di dalam tubuh agar bisa hidup sehat dan produktif. Status gizi yang baik akan turut berperan dalam pencegahan terjadinya berbagai penyakit, khususnya penyakit infeksi dan dalam tercapainya tumbuh kembang anak yang optimal

Pada remaja, kejadian kegemukan dan obesitas merupakan masalah yang serius karena akan berlanjut hingga usia dewasa. Masalah obesitas pada dewasa ini merupakan faktor risiko terjadinya berbagai penyakit metabolik dan degeneratif seperti penyakit kardiovaskuler, diabetes mellitus, kanker, osteoarthritis,

dan lain-lain. Pada anak usia 13- 18 tahun, kegemukan dan obesitas juga dapat mengakibatkan berbagai masalah kesehatan yang sangat merugikan kualitas hidup anak seperti gangguan pertumbuhan tungkai kaki, gangguan tidur, sleep apnea (henti napas sesaat) dan gangguan pernafasan lainnya. Edukasi Kesehatan dirasa sangat diperlukan terutama kegiatan yang berhubungan dengan pentingnya gizi seimbang dan aktivitas fisik.

Masalah gizi lebih atau obesitas merupakan masalah global dan menjadi masalah utama di negara-negara maju dan berkembang karena mengalami peningkatan tiap tahun. Obesitas merupakan masalah karena lemak yang terdapat di dalam tubuh mengalami kelebihan, hal ini akan berdampak negatif pada kesehatan masyarakat. Berdasarkan data dari WHO tahun 2010 prevalensi obesitas dari tahun 1990 sebesar 4,2%, pada tahun 2010 meningkat menjadi 6,7% (World Health Organization, 2015). Di Indonesia, masalah gizi lebih atau obesitas juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Data Riset Kesehatan Dasar, pada tahun 2007 sebesar 10.5%, tahun 2013 persentase sebesar 14.8%, dan 2018 persentase sebesar 21.8%. Khususnya kondisi obesitas sentral pada usia > 12 tahun terdapat 18.8% tahun 2007, sebesar 26.6% tahun 2013 dan 31.0% pada tahun 2018. Kondisi ini dapat dialami oleh setiap golongan usia, baik laki-laki maupun perempuan

(Kementerian Kesehatan RI, 2018). Masalah obesitas bagi usia remaja dapat menyebabkan berbagai macam penyakit tidak menular, seperti stroke, jantung, dan diabetes melitus tipe 2 yang merupakan penyebab utama kematian di tahun 2012. Namun, tidak hanya itu beberapa penyakit lainnya seperti muskuloskeletal (osteoarthritis, cedera) dan beberapa jenis kanker termasuk endometrium, payudara, ovarium, prostat, hati, kandung empedu, ginjal dan usus besar.

Upaya perbaikan status gizi lebih optimal yaitu dengan kombinasi konseling gizi dan program latihan stretching efektif dalam perbaikan status gizi (Gifari, Kuswari, & Azza, 2018). Remaja yang memiliki asupan zat gizi makro berlebih, frekuensi konsumsi fast food sering, aktivitas fisik tidak aktif, memiliki ibu dan ayah dengan status obesitas, serta tidak sarapan, berisiko lebih terhadap terjadinya obesitas (Kurdanti et al., 2015)(Thaddanee, Chaudhari, Thakor, Thaddanee, & Pediatr, 2016). Dengan adanya edukasi gizi seimbang dan aktivitas fisik secara terus menerus diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan gizi dan juga perbaikan perilaku menjadi lebih baik.

3. Kehamilan Usia Remaja

Menurut World Health Organization (WHO), 16 juta anak perempuan di dunia melahirkan setiap tahun, terdiri dari 12 juta anak perempuan berusia 15 sampai

19 tahun dan setidaknya 777.000 anak perempuan dibawah 15 tahun melahirkan di wilayah negara berkembang (Darroch, 2016). Selain karena perilaku seksual yang menyimpang, kehamilan usia remaja juga disebabkan oleh perkawinan usia remaja.

Perawatan kehamilan merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan untuk mencegah terjadinya komplikasi dan kematian ketika persalinan, serta untuk menjaga pertumbuhan dan kesehatan janin. Bentuk perawatan kehamilan yang perlu diperhatikan mulai dari perawatan diri (kulit, gigi dan mulut, serta perawatan kuku), payudara, imunisasi, senam hamil, pemeriksaan kehamilan, serta gizi untuk perkembangan janin. Perawatan kehamilan dipengaruhi oleh faktor predisposing (pengetahuan), faktor pendorong (peran suami) dan faktor penguat. Pengetahuan merupakan suatu bentuk pemahaman ibu hamil dalam melakukan perawatan kehamilan, peningkatan pengetahuan yang dimiliki ibu hamil bersumber dari literasi kesehatan yang membahas mengenai perawatan kehamilan.

4. Perilaku Merokok

Setiap periode tumbuh kembang mempunyai tahapan tersendiri, namun masa remaja sering menjadi masalah yang sulit diatasi oleh anak laki-laki maupun anak perempuan. Kesulitan pertama, masalah anak yang sebagian besar diselesaikan oleh orang tua dan guru

mengakibatkan remaja tidak berpengalaman dalam mengatasinya. Kedua, karena remaja merasa telah mandiri, sehingga mereka ingin mengatasi masalahnya sendiri, menolak bantuan orang tua dan guru. Sedangkan masalah dikalangan remaja yang banyak terjadi antara lain ketergantungan obat, ketergantungan alkohol, dan ketergantungan terhadap rokok.

Di Indonesia, jumlah kematian akibat penyakit yang disebabkan dari kebiasaan merokok mencapai 300 ribu pertahun. Hampir 60 persen kematian di Indonesia disebabkan oleh penyakit tidak menular (PTM) yang disebabkan oleh rokok seperti stroke, hipertensi dan penyakit jantung yang kini jumlahnya semakin meningkat. Hal tersebut, merupakan ancaman bagi pertumbuhan ekonomi, karena PTM yang semula terjadi pada usia lanjut kini mulai menyerang pada usia yang lebih muda.

Perilaku merokok berkaitan dengan pengetahuan, sikap seseorang terhadap rokok dan pendidikan. Di Indonesia, belum ada kurikulum khusus tentang masalah berhubungan dengan rokok. Informasi bahaya merokok dimasukkan sebagai salah satu topik dalam mata pelajaran Biologi dan Pendidikan Jasmani. Pengetahuan yang cukup akan memotivasi individu untuk berperilaku sehat. Orang yang dipenuhi banyak

informasi (pengetahuan) akan mempersepsikan informasi tersebut sesuai dengan predisposisi psikologisnya. Pengetahuan yang memadai tentang bahaya rokok bagi kesehatan diharapkan membuat orang yang belum merokok tetap tidak merokok dan para perokok yang sudah terlanjur bisa menghentikan kebiasaan yang sangat berbahaya ini.

Pendidikan kesehatan merupakan penambahan pengetahuan dan kemampuan seseorang melalui teknik praktik belajar atau instruksi secara individu untuk meningkatkan kesadaran akan nilai kesehatan sehingga dengan sadar mau mengubah perilakunya menjadi perilaku sehat.

E. Upaya Pencegahan Masalah Kesehatan Pada Remaja

1. Program Kesehatan Remaja

Merujuk pada permasalahan yang ada dalam rangka mengoptimalkan dan meningkatkan kesehatan, kesejahteraan sosial dan kemampuan usia remaja, perlu di selenggarakan suatu program pelayanan dan pengembangan untuk masalah tersebut. Upaya perlu dilakukan berkesinambungan agar tercapai kualitas hidup yang optimal pada usia remaja. Pendekatan program pelayanan difokuskan pada program terpadu melalui pemberdayaan dan peran serta aktif masyarakat. Pemberdayaan peran serta remaja sebagai kader kesehatan dapat diupayakan untuk

mengoptimalkan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bagi permasalahan kesehatan remaja.

Pemberdayaan dan peran serta aktif masyarakat (remaja) akan menghasilkan kemandirian remaja, kemampuan untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi serta membuat perencanaan dan upaya pemecahan masalah dengan memanfaatkan potensi yang ada tanpa tergantung pada bantuan dari luar. Potensi cukup besar untuk dapat meningkatkan pemberdayaan remaja, antara lain dilihat dari banyaknya remaja yang memiliki pendidikan yang cukup, status ekonomi masyarakat yang sebagian besar sejahtera dan lingkungan rumah saling berdekatan sehingga mudah koordinasi kegiatan.

2. Pendidikan Kesehatan

Pendidikan kesehatan adalah aplikasi atau penerapan pendidikan di dalam bidang kesehatan. Secara operasional pendidikan kesehatan adalah semua kegiatan untuk memberikan dan atau meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktek baik individu, kelompok atau masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Pendidikan kesehatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendidikan kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan diri.

Pendidikan kesehatan adalah segala upaya yang direncanakan dalam mempengaruhi orang lain dalam menyadarkan atau merubah sikapnya di bidang kesehatan agar lebih baik. Pendidikan kesehatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendidikan kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan diri.

Pendidikan kesehatan merupakan penambahan pengetahuan dan kemampuan seseorang melalui teknik praktik belajar atau instruksi secara individu untuk meningkatkan kesadaran akan nilai kesehatan sehingga dengan sadar mau mengubah perilakunya menjadi perilaku sehat.

3. Pola Asuh Yang Baik

a. Menanamkan karakter sejak kecil pada anak

Menanamkan karakter sejak kecil yang dimaksud adalah pendidikan agama sejak dini karena dengan pendidikan agama yang baik sejak dini maka anak akan tumbuh dengan karakter yang baik. Menanamkan karakter sejak kecil dapat dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat yang berfungsi sebagai perbaikan, penyaluran, pencegahan, pengalamanserta mampu menjadi pengajaran bagi anak. Bahwa dalam upaya penanggulangan kenakalan remaja dengan cara preventif dapat dilakukan dengan cara menanamkan

karakter sejak kecil pada anak yang pada hal ini pendidikan agama yang paling penting.

b. Perhatian yang lebih dari orangtua

Upaya orangtua selanjutnya yaitu memberikan perhatian yang lebih dari orangtua jika anak berada di rumah atau di luar rumah selalu di berikan perhatian yang lebih terhadap tingkah lakunya. perhatian yang lebih harus diberikan kepada anak agar anak merasa dipedulikan dan tidak merasa ditelantarkan karena salah satu penyebab kenakalan pada anak remaja karena merasa tidak nyaman berada di lingkup keluarganya. Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa penegak hukum berharap kepada orangtua agar meningkatkan perhatian pada anak agar tidak mendapatkan kenyamanan di luar yang membuatnya bebas dalam bergaul. Upaya yang dilakukan oleh orangtua yaitu memberikan perhatian yang lebih baik di lingkungan dalam rumah maupun di luar rumah agar anak merasa dipedulikan

c. Mengajak anak untuk mengikuti kegiatan kemasyarakatan

Upaya lain yang dilakukan yaitu dengan mengajak anak melakukan kegiatan kemasyarakatan seperti mengajaknya masuk organisasi karang taruna, remaja masjid, gotong royong, perkumpulan

penggemar olahraga. Karena menurutnya dari pada berbuat yang aneh aneh.

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa Membiarkan anak remaja untuk ikut dalam kegiatan kemasyarakatan menjadi jalan yang efektif untuk anak remaja memanfaatkan waktu luangnya untuk bertukar pikiran, gagasan dan ide terhadap sebayanya. Karena hal-hal seperti ini lebih positif dengan mengeluarkan kreatifitasnya. Mengajak anak untuk ikut kegiatan kemasyarakatan itu mampu mencegah terjadinya kenakalan remaja, terlebih organisasi karang taruna merupakan wadah di mana remaja mampu menyumbangkan ide, gagasan, pikiran dan ajang silaturahmi antara remaja dengan remaja lainnya. Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa pemerintah sudah memberikan wadah untuk anak remaja dalam mengembangkan potensinya yaitu di dalam organisasi kepemudaan karang taruna dan perkumpulan lainnya yang lebih positif.

Referensi

- Afrianti, N. (2017). *Analisis implementasi program pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR)*. Universitas Syiah Aceh.
- Afrianti, N., & lainnya. (2017). Analisis implementasi program pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR). *Public Health Centres*, (Tidak disebutkan volume), 47–53.
- Fakultas Ilmu Kesehatan, & lainnya. (2020). *Asuhan keperawatan keluarga dengan tahap perkembangan keluarga remaja 1*, 33.
- Hapsari, A. (2019). *Buku ajar kesehatan reproduksi*.
- Ilfa, K., & Rahman, D. (2022). Literasi kesehatan sebagai upaya peningkatan perilaku kesehatan remaja. *Jurnal Kesehatan*, 7(April), 1–8.
- Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam. (2021). Peran keluarga dalam penanggulangan kenakalan remaja. *Jurnal Ilmiah*, 8, 47–71.
- Marbun, R., & Dea, V. (2021). Edukasi kesehatan pada remaja dalam pentingnya gizi seimbang dan aktivitas fisik di era pandemi COVID-19. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 4, 508–512.
- Nuradita, E., & lainnya. (2018). Pengaruh pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan tentang bahaya rokok pada remaja di SMP Negeri 3 Kendal. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 1(1), 44–48.

- Putri, N. T., Azinar, M., & Info Artikel. (2022). *Higeia Journal of Public Health*, 6(1), 47–53.
- Seminar Nasional Pendidikan, & lainnya. (n.d.). Optimalisasi status kesehatan remaja melalui (hal. 20–24).
- Sembada, S. D., & Pratomo. (2022). Pemanfaatan media online sebagai sarana edukasi kesehatan pada remaja: Tinjauan literatur. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 6(April), 564–574.
- Setianingsih, W. (2017). (Soft lens) dalam perawatan kesehatan mata di SMKN 3 Kota Blitar (The behavior of adolescents with contact lens (soft lens) in the eye health care in SMKN 3 Blitar City). *Jurnal Kesehatan Mata*, 3, 218–223.
- Yatimah, D., & lainnya. (2023). Penyuluhan kesehatan sistem reproduksi sebagai upaya meningkatkan perawatan kesehatan remaja. *Jurnal Kesehatan*, 3(4), 737–744.

Glosarium

KHA = Konversi Hak Anak

ICPD = International Population and Development

PTM = Penyakit Tidak Menular

BAB 2

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) di Komunitas

Lindawati Simorangkir, S.Kep., Ns., M.Kes.

A. Pendahuluan

PTM merupakan prioritas gangguan kesehatan secara global. PTM contoh penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, DM, ginjal dan PPOK menyebabkan utama kematian dan kecacatan. Diperkirakan 17 juta lansia meninggal dan 86% meninggal usia dini di beberapa negara yang berpenghasilan rendah (*low-and middle income countries*) (WHO,2023). PTM juga dapat menghabiskan biaya yang cukup tinggi, membutuhkan perawatan waktu yang lama, teknologi yang mahal (Rahayu, D., & dkk, 2021).

Tingginya prevalensi PTM ini disebabkan oleh perubahan gaya hidup modern yakni konsumsi *fast food*, kurang aktivitas, konsumsi alkohol, merokok, dan penggunaan obat-obatan (B, H., Akbar,K., 2021). Hal ini mengakibatkan menurunnya kemampuan sumber daya manusia, menurunnya kemampuan berdampak pada kemajuan ekonomi suatu bangsa jika tidak dilakukan pencegahan dan pengendalian PTM secara tepat, benar, dan berkelanjutan (Nurdin, A., & Rahayu, 2024). Upaya pencegahan dan pengendalian PTM diarahkan kepada faktor resiko.

B. Konsep Penyakit Tidak Menular

1. Proses Terjadinya PTM

PTM ialah penyakit yang bukan ditularkan atau dari manusia ke manusia lainnya. PTM ini adalah masalah kronis, berlangsung dengan waktu yang cukup lama, yang dapat disebabkan oleh banyak faktor resiko misal konsumsi makanan cepat saji, malas olahraga, merokok, mengkonsumsi alkohol, dan stress. Penyakit Tidak Menular ialah *silent killer*, mengancam nyawa sehingga menimbulkan morbiditas dan mortalitas di seluruh dunia antara lain yakni penyakit kardiovaskular dan serebrovaskular, kanker, PPOK, dan DM (Nies, M. A., & McEwen, 2019).

Faktor resiko terjadinya PTM sebagian besar ialah faktor yang bisa dimodifikasi/dicegah. Faktor resiko PTM ialah suatu keadaan kemungkinan besar bisa menimbulkan terjadinya penyakit tidak menular pada manusia. Faktor

risiko PTM yang bisa dimodifikasi/dicegah ialah; perilaku yang berisiko (merokok, Konsumsi sayur dan buah rendah, konsumsi natrium berlebih, malas olah raga, minum alkohol dan kecemasan); determinan lingkungan (pencemaran udara, transportasi tidak layak operasional, bahan kimia bersifat karsinogenik); determinan fisiologi (kegemukan, hyperkolesterol). Faktor risiko PTM yang tidak bisa dimodifikasi ialah umur, jenis kelamin dan genetik).

2. Ciri - Ciri Penyakit Tidak Menular

PTM memiliki beberapa ciri-ciri yang dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Penyebaran bakteri tidak melalui suatu rantai penyebaran tertentu

Penyakit tidak menular disebabkan oleh *non living agent* seperti fisik, kimiawi, mekanik dan psikis. Faktor risiko dapat mempengaruhi independen terjadinya penyakit tidak menular. Contohnya Seseorang obesitas berpeluang 4,6 lebih besar terjadi penyakit tidak menular (Alwa, M., Syafriani, S., & Lasepa, 2024).

- b. Masa inkubasi yang panjang dan *laten*

Masa inkubasi adalah waktu yang dibutuhkan dari saat terpapar penyakit sampai menunjukkan gejala awal. Penyakit tidak menular membutuhkan waktu yang cukup lama karena penyebab dari penyakit tidak menular bukan mikroorganisme. Contoh orang memiliki kebiasaan *junk food* maka 5-10 tahun

kedepan individu tersebut berisiko terjadi penyakit tidak menular (Hasanah, 2024).

c. Penyakit berlangsung lama/kronis

Penyakit tidak menular merupakan penyakit menahun karena faktor penyebabnya multifaktor, menyebabkan kerusakan fungsi sistem tubuh, dan tidak dapat di sembuhkan akan tetapi dapat dikontrol.

d. Diagnosis sulit ditegakkan

Penyakit tidak menular tidak pernah memperlihatkan gejala yang istimewa dan tidak disadari oleh pasien. Pada saat pasien sudah merasakan tanda gejala yang serius baru menyadari bahwa dirinya sudah penyakit kronis.

e. Membutuhkan biaya yang cukup mahal

Penyakit tidak menular untuk kesembuhan sangat kecil, menimbulkan kecacatan dan memerlukan teknologi tinggi sehingga memerlukan biaya yang cukup tinggi.

f. Faktor penyebabnya banyak (*multikausal*)

Penyebab penyakit tidak menular tidak cukup satu faktor akan tetapi akumulasi dari beberapa faktor resiko yang saling berinteraksi yang dapat berkontribusi terjadinya suatu penyakit.

g. Memiliki variasi yang banyak

Varian penyakit tidak menular cukup banyak

3. Jenis Penyakit Tidak Menular

a. Penyakit Kardiovaskuler

Penyakit jantung dan pembuluh darah merupakan penyebab mortalitas urutan pertama di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Di Indonesia, diperkirakan 15 dari 1000 orang atau $\pm 2.784.064$, terdiagnosis penyakit jantung (Rikesdas., 2018). Penyakit ini sering terjadi pada pada kelompok usia 45-64 tahun, tanpa memperhatikan jenis kelamin, dan tingkat ekonomi. Penyakit jantung dan pembuluh darah banyak ditemukan di komunitas belakangan ini adalah PJK, stroke, CHF dan hipertensi.

Faktor risiko penyakit kariovaskuler yang kerap dijumpai di komunitas yakni kerap menghabiskan gorengan dengan minyak sekali pengorengan ataupun pengorengan ulang, hal ini menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah. Kebiasaan menghabiskan gorengan berumur lebih 3 tahun dengan jumlah lebih 1 kali per hari sebanyak 41,7% (Rikesdas., 2018). Hasil penelitian Honerlaw pada tahun 2020 menjelaskan bahwa mengkomsumsi gorengan berisiko tinggi terjadinya PJK (Husna, D. S., & Puspita, 2020).

Lemak adalah komponen yang mempunyai dampak terhadap pengaturan metabolisme kolesterol. Kadar lemak yang tinggi pada makanan dapat menambah

kadar kolesterol total dalam darah dan membuat endapan pada arteri menyebabkan aterosklerosis. Aterosklerosis yang terdapat pada arteri dapat mengakibatkan PJK (Hanifah, W., Wanda, O. S., & Nisa, 2020).

Penyebab utama penyakit kardiovaskuler yakni aterosklerosis. Aterosklerosis adalah menebalnya dan berkurangnya kelenturan dinding arteri sehingga suplai oksigen dan nutrisi ke jantung berkurang. Aterosklerosis dapat menyebabkan PJK, stroke dan hipertensi.

Aterosklerosis ialah penyakit akibat stimulus peradangan pada arteri yang cepat. Hal ini mengakibatkan penebalan pada dinding arteri akibat proses sedimentasi lemak, karbohidrat, dan produk darah, sehingga hilangnya kelenturan pembuluh darah.

Plak yang pecah merangsang trombosit menyebabkan pembentukan trombus. Trombus menghambat aliran darah, menyebabkan terjadinya sindrom koroner akut (SKA), kemudian menyebabkan infark miokard akut (IMA), dan akhirnya terjadi nekrotik.

Tanda dan gejala penyakit jantung koroner sangat bervariasi dari yang tanpa gejala sama sekali hingga berat. Gejala yang sering tampak pada PJK yakni:

- 1) Nyeri dada yang dapat menjalar ke lengan, leher, rahang atau punggung.
- 2) Sesak napas.
- 3) Kelelahan yang tidak berhubungan dengan aktivitas fisik.
- 4) Nyeri dada yang terjadi pada istirahat atau tidur.
- 5) Infark miokard.

b. Penyakit Serebrovaskular

Penyakit serebrovaskular adalah suatu ketidaknormalan fungsi sistem saraf pusat akibat kurangnya suplai darah ke otak. Stroke juga berkontribusi terhadap peningkatan kasus penyakit tidak menular yang prevalensinya terus meningkat. Penyakit serebrovaskular merupakan masalah serius di seluruh dunia. Penyakit ini dapat mengakibatkan kematian, kecacatan fisik, dan mental pada semua tingkat usia (Daulay, N. M., et al., 2023). WHO memprediksi pada tahun 2030 8 juta jiwa akan meninggal akibat stroke (Tjondronegoro, A., Azizah, A. M. N., & Claudia, 2023). Secara global pada tahun 2022 ditemukan sebanyak 12,2 juta kasus baru stroke, di Indonesia terdapat 131,8 kasus/100 ribu penduduk (Marliana, 2021).

Faktor risiko terjadinya penyakit serebrovaskuler dapat dibedakan berdasarkan faktor yang dapat diubah/ tidak bisa dimodifikasi dan tidak dapat diubah/ modifikasi. Faktor risiko yang dapat diubah/ dimodifikasi ialah minum alkohol, kebiasaan merokok, kurang olah raga, konsumsi *fast food*, dan perilaku hidup tidak sehat. Faktor yang tidak bisa dimodifikasi umur, jenis kelamin, suku, dan genetik.

Strok ialah serangan neurologi tiba-tiba yang disebabkan oleh gangguan perfusi pembuluh darah ke otak. Lebarnya kematian tergantung pada determinan misal lokasi dan luasnya arteri dan lancarnya peredaran paralel oleh pembuluh darah yang terhenti. Persediaan darah keotak dapat berganti akibat trombus, emboli, perdarahan, dan spasme vaskular) atau disebabkan kurangnya oksigen akibat penyakit paru dan jantung). Arteriosklerosis merupakan faktor yang mengakibatkan kematian jaringan otak.

Trombus bisa mengakibatkan iskemik jaringan otak, retensi cairan dan penimbunan disekitar area. Edema pada otak disebabkan gangguan fungsi yang lebih luas, bisa terjadi beberapa jam atau beberapa hari. Oklusi pada pembuluh darah otak yang disebabkan oleh embolus menyebabkan edema dan trombosis sehingga terjadi kematian sel sebelum waktunya.

Masalah yang sering dirasakan oleh pasien stroke yakni ketidakmampuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari akibat kelemahan anggota tubuh. Tanda dan gejala yang dapat dilihat dari pasien stroke yakni senyum tidak simetris, gerak tubuh lemah, bicara pelo, separuh tubuh terasa kesemutan, rabun pada mata terjadi secara tiba-tiba, dan sakit kepala hebat.

Pemberian pendidikan kesehatan kepada klien dan keluarga selama dirawat di rumah sakit sangat penting dilakukan. Penyakit stroke 90% dapat dicegah dengan melakukan olah raga ringan 5 kali seminggu minimal 30 menit, kontrol tekanan darah, kontrol kadar kolesterol, perbanyak konsumsi buah dan sayuran, kurangi konsumsi garam, mempertahankan berat badan ideal, tidak merokok, menjauhi asap rokok, dan tidak konsumsi alkohol. Latihan otot dan pergerakan harus secara rutin dilakukan untuk mencegah komplikasi pada sisi tubuh yang lemah.

Kelurga sangat penting diberikan informasi atau penjelasan tentang perubahan emosional dan kognitif sering terjadi pada pasien akibat kemahan/kelumpuhan pada ekstermitas atas dan bawah yang dapat menimbulkan perubahan perilaku, kurang mampu mengambil keputusan, dan depresi.

c. Diabetes Mellitus

DM adalah penyakit yang kompleks ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi akibat ketidakmampuan tubuh memproduksi insulin atau ketidakmampuan tubuh menggunakan insulin dengan baik. Ketidakseimbangan metabolisme pada penyakit ini beresiko tinggi terjadi komplikasi makrovaskuler dan mikrovaskuler, yang menyebabkan gangguan pada ginjal, jantung dan mata.

DM ialah penyakit menahun dengan morbiditas dan mortalitas yang tinggi di Indonesia dan merupakan prioritas utama di daerah perkotaan. Diperkirakan pada tahun 2023 di Indonesia, penyakit DM ditemukan 21,3 juta jiwa (Tanty, H. N., Fidia, F., & Meryta, 2024). International Diabetes Federation (IDF) memprediksi prevalensi global penyakit diabetes mencapai angka 578 juta jiwa pada 2030 dan 700 juta jiwa pada tahun 2045. Kasus penyakit DM akan terus meningkat seiring bertambahnya usia yakni 111,2 juta jiwa pada usia 65 – 79 tahun (Aisyah, R., & dkk, 2024).

Penyakit DM dibagi menjadi 2 tipe yakni Tipe I dan Tipe II. Dm tipe I ialah ketergantungan insulin dan DM tipe II ialah tidak ketergantungan insulin. Determinan terjadinya penyakit DM ialah genetik, autoimunitas, gaya hidup, berat badan berlebih, budaya, gangguan metabolik, dan lingkungan.

Seseorang yang memiliki berat badan berlebih dan dalam keluarga ada yang riwayat sakit DM, maka seseorang itu akan beresiko tinggi terkena penyakit DM tipe II. Resistensi insulin dapat menghambat absorpsi glukosa ke dalam otot dan hati sehingga terjadi gangguan sekresi insulin. Gangguan sekresi insulin sehingga produksi insulin tidak tercukupi mengakibatkan hiperglikemia. Hiperglikemia kronis dapat menyebabkan gangguan pada beberapa organ seperti mata, ginjal dan pembuluh darah. Apabila terjadi hipoglikemia dapat menyebabkan kelemahan, mengantuk, gemetar, dan mudah tersinggung, dan dalam kasus serius dapat menyebabkan gangguan kesadaran dan kerusakan otak. Penyakit DM berisiko 2-4 kali lebih tinggi untuk terjadi gangguan fungsi jantung yang menimbulkan iskemik, stroke dan kematian dibandingkan yang tidak terdiagnosis penyakit DM.

Sejumlah gejala klasik kerap dirasakan oleh pasien DM ialah poliuri (banyak kecing) pada malam hari, polidipsi (banyak minum), polipaghi (banyak makan), berat badan berkurang tanpa penyebab yang jelas, mudah lelah, kesemutan, penglihatan kabur, dan luka yang lama sembuh.

Ada beberapa test diagnostik untuk menengakan diagnosis penyakit DM antara lain;

- 1) Tes Glukosa Darah Puasa (FPG): Mengukur kadar glukosa setelah puasa semalam (70-100 mg/dl). Puasa disini dalam arti tidak mengkomsumsi makanan selama 8 jam.
- 2) Tes Toleransi Glukosa Oral (OGTT): Mengukur kadar glukosa setelah puasa dan 2 jam setelah mengonsumsi makanan (<140 mg/dl)
- 3) Tes HBA1c: Menilai rata-rata kadar gula dalam darah selama 3 bulan terakhir (<5,7%).

Ada beberapa komplikasi yang terjadi pada pasien DM jika tidak dilakukn tindakan dengan cepat dapat bersifat akut dan kronik sebagai berikut.

- 1) Komplikasi akut
 - a) Hiperglikemia dapat terjadi ketonacidosis diabetes (KAD) kadar gula darah (300 -60 mg/dl), terjadi asidosis, plasma keton (+), dan osmolaritas plasma tinggi (300 -320 mOs/ml), serta anion gap tinggi.
 - b) Hipoglikemia diman gula darah < 70 mg/dl
- 2) Komplikasi kronis
 - a) Makroangiopati menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah yang dapat sehingga terjadinya stroke, PJK, iskemik pada kaki dan ulkus.
 - b) Mikroangiopati menyebabkan resiko terjadi retinopati diabetik.

Upaya preventive untuk menghindari terjadinya komplikasi pada penyakit DM adalah sebagai berikut:

1) Diet

Nutrisi yang tepat sangat penting dalam pengendalian penyakit DM. Memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga dan pasien terkait makanan sehat, kontrol porsi, makanan yang seimbang dengan mengkomsumsi makanan rendah lemak, kaya serat, dan meninggalkan gula tambahan

2) Pemantauan gula darah

Kadar gula darah dalam batas normal mengurangi terjadinya komplikasi yang pada neuropatik dan pembuluh darah.

3) Terapi insulin dan menormalkan aktivitas insulin

Manajemen insulin sangat efektif untuk mengendalikan gula darah terkhusus pada pasien yang terdiagnosis DM tipe I.

4) Aktivitas

Aktivitas merupakan bagian yang sangat krusal untuk mengontrol kadar gula darah. Olah raga merupakan sensitiser yang baik untuk insulin, dan dapat memperkuat pengakuatan glukosa ke dalam sel otot skeletal. Olah raga dapat dilakukan secara rutin paling tidak 150 menit/minggu. Olah raga tidak dianjurkan pada saat kadar gula darah > 250 mg/dl dan ketosis, karena dapat menyebabkan stres fisiologi pada tubuh .

d. Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK)

PPOK adalah penyakit saluran pernapasan menahun yang dibuktikan oleh sumbatan sirkulasi udara yang bersifat permanen, partial dan berkaitan dengan meningkatnya stimulus inflamasi saluran napas yang disebabkan partikel tertentu.

PPOK adalah urutan ketiga penyebab kematian di dunia; 90% terjadi dinegara yang berpenghasilan rendah dan menengah, termasuk Indonesia. Diperkirakan > 3 juta jiwa meninggal karena PPOK setiap tahunnya, > 5% total penyebab kematian secara global (Tifany, E. P., & Tambunan, 2023).. Berdasarkan WHO pada tahun 2023, PPOK masuk urutan ke 7 penyakit terbesar diseluruh dunia yang dinilai berdasarkan tingkat kecacatan dan lamanya tahun hidup (Parums, 2023). Kasus PPOK terus meningkat dengan bertambahnya jumlah perokok karena etiologi primer PPOK ialah perokok aktif dan pasif, dan udara kotor di luar maupun di dalam ruangan. Di Indonesia kasus PPOK mencapai 9,2 juta jiwa atau 3,7%, prevalensi PPOK terbanyak di NTT sebesar 10,0%, diikuti sulawesi tengah sebanyak 8,0%, (Sari, P. I., & Maghfirah, K. (2024).

Determinan terjadinya PPOK ialah keturunan, perokok aktif dan pasif, polusi udara, usia, infeksi berulang, dan status ekonomi rendah. Laki-laki lebih berisiko

tinggi terkena PPOK disebabkan kebiasaan merokok. Laki-laki perokok 1,26 kali berisiko terkena PPOK, laki-laki yang bekerja di luar ruangan yang sering terpapar polusi udara baik asap kendaraan motor, asap pabrik, asap rokok dan debu 0,63 kali lipat berisiko terkena PPOK.

Keunikan primer PPOK ialah hambatan sirkulasi udara sehingga ekspirasi lebih panjang. Sumbatan jalan napas dan meningkatnya *compliance paru* menyebabkan ekspirasi lebih panjang. Untuk mengetahui tinnginya *compliance paru* dengan cara mengukur volume ekspirasi paksa detik pertama (FEV1), dan rasio FEV1 dengan kapasitas vital paksa (FEV1.FVC).

Tanda gejala yang sering muncul pada pasien PPOK ialah batuk yang sering muncul pada saat pagi hari, sesak napas, hipersekresi sputum, bunyi napas wheezing akibat adanya eksaserbasi akibat adanya mikroorganisme, suara napas ronchi akibat penumpukan sputum di jalan napas dan paru, takipnea dan distress pernapasan pada saat melakukan aktivitas, penggunaan otot bantu napas dan terjadi sianosis akibat suplay oksigen dalam tubuh menurun. Beberapa pemeriksaan diagnostik untuk menegaskan diagnosis PPOK sebagai berikut: Tes fungsi paru spirometry (Gold Standar), radiologi (Rontgen

Thoraks), Pemeriksaan gas darah (AGD), pemeriksaan darah rutin, dan pemeriksaan mikrobiologi sputum.

Komplikasi yang akan terjadi pada PPOK jika tidak ditangani dengan baik yakni Cor pulmonale, PPOK eksaserbasi, gagal napas akut, depresi dan ansietas, serta narcosis CO₂. Peran tenaga kesehatan sangat besar dalam program rehabilitasi dan memfasilitasi dalam meningkat pengetahuan tentang proses penyakit. Manajemen penatalaksanaan pasien PPOK yang utama dapat dilakukan dengan berhenti merokok. Olah raga ringan sangat dianjurkan pada klien PPOK seperti jogging, jalan santai dan bersepeda. Latihan pernapasan dengan melakukan pernapasan diafragma dan *pursed lips breathing*. Therapi oksigen mengurangi sesak, mencegah hipertensi pulmonal, mencegah vasokonstriksi dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Pemberian vaksinasi *influenza vaccine* dan *pneumococcal vaccine*. Modifikasi gaya hidup dan meningkatkan mekanisme koping sangat penting pada pasien PPOK.

e. Kanker

Kanker ialah bagian dari PTM, penyakit menahun yang membutuhkan penanganan dan pengobatan yang cukup. Penyakit kanker yang terjadi pada jaringan tubuh yang terdapat sel-sel tidak normal yang hidup

secara cepat, tidak terkoordinasi dan dampak kematian terbanyak di dunia.

World Health Organization menyatakan bahwa diperkirakan 70% meninggal akibat kanker terjadi di negara yang berkembang dan 9,6 juta jiwa di dunia meninggal, pada tahun 2020 mencapai 19,3 juta jiwa dengan mortalitas sampai 10 juta jiwa (WHO.Int, 2023). Data Global Burden of Cancer Study (Globocan) melaporkan kasus kanker di Eropa 4.230.000 kasus, di Asia 8.751.000 kasus, Amerika Serikat 3.792.000 Kasus (Rosaria, Susilowati dan Septimar, 2024) dan (Kesehatan, J. I., Emilia, M., & Alpiyah, 2024).

Di seluruh dunia, diprediksikan 19,3 juta kasus kanker baru terjadi pada tahun 2020, dengan prevalensi kanker payudara diprediksikan 2,3 juta (11,7%) kasus baru, kanker paru sebanyak 11,4%, kanker kolorektal sebanyak 10%, kanker prostat sebanyak 7,3%, dan kanker abdomen sebanyak 5,6%. (Sung et al, 2021). Di Indonesia jumlah penderita kanker mencapai 1.79/1000 jiwa (4,1%), kasus tertinggi di Yogyakarta sebanyak 4.86/1000 jiwa, diikuti Sumatera 2.47, di Jawa juga merupakan jumlah penyakit kanker terbanyak, yakni 68.638 dan 61.230 jiwa (2,1%), dan Gorontalo 2.44 (0,2%) (Tanrewali, M. S., & Wahyuningsih, 2019).

Faktor resiko kanker payudara terdiri dari faktor hormonal, faktor genetik, gaya hidup, dan terpapar radiasi. Penjelasan dari masing-masing faktor resiko tersebut adalah sebagai berikut:

1) Faktor Genetik

Seseorang yang memiliki keluarga dengan riwayat kanker payudara, beresiko sekitar dua kali lipat terkena kanker payudara dibandingkan dengan wanita tanpa riwayat kanker payudara. Salah satu gen yang diturunkan dari keluarga yang memiliki riwayat kanker payudara adalah gen BRCA1 dan BRCA2. Apabila gen tersebut dalam tubuh manusia ini mengganggu, perubahan fungsi, dan bermutasi, sehingga fungsinya akan terganggu maka akan beresiko terkena kanker payudara.

2) Faktor Hormonal

Paparan hormon ovarium (estrogen) merupakan faktor utama penyebab kanker payudara, sehingga perempuan 100 kali lebih mungkin terserang kanker payudara dari pria. Semakin banyak terpapar hormon estrogen semakin rentan seorang wanita terhadap kanker payudara.

3) Terpapar Radiasi

Perempuan yang berdomisili di Hiroshima Jepang yang berusia dibawah 20 tahun ketika bom nuklir diluncurkan memiliki 15 kali lipat peningkatan resiko kanker dibandingkan dengan perempuan

yang tidak terpajan radiasi. Eksposur untuk mengionisasi radiasi dari kecelakaan nuklir atau medis prosedur meningkatkan resiko kanker payudara, terutama jika pemaparan terjadi usia dibawah 40 tahun.

4) Gaya Hidup

Gaya hidup tidak sehat 90 -95 % faktor resiko terjadinya penyakit kanker. Perilaku hidup tidak sehat seperti merokok, makan makanan instan, konsumsi alkohol, obesitas, dan kurang olah raga meningkatkan resiko kanker 25 -30% kematian terkait kanker.

Penyakit kanker tidak menunjukkan gejala, namun terdapat faktor yang mempengaruhi sel kanker untuk terus berlanjut menyebar didalam tubuh. Selanjutnya faktor yang menjadi pemicu menyebarnya sel kanker dapat dipengaruhi oleh perilaku hidup yang tidak sehat, diantaranya yaitu: merokok, mengkonsumsi junk-food berlebihan, konsumsi alkohol, dan kurang aktivitas fisik.

Sel kanker terdiri dari sel normal yang berproses melalui proses modifikasi fase iniasi dan promosi. Pada fase inisiasi, terdapat pengantian material genetis sel memicu sel membuat ganas. Penggantian sel genetis disebabkan faktor pencetus kanker yang terdapat dalam zat kimia, radiasi, dan sinar matahari.

Pada fase promosi, sel menjadi ganas karena adanya kombinasi antara sel yang sensitif dengan karsinogen. Kemudian perlahan akan menimbulkan gejala-gejala yang dialami pasien kanker, karena kedua tahapan tersebut menimbulkan imunnitas tubuh berusaha merusak sebelum sel berduplikasi dan bertransformasi menjadi kanker. Immunitas tubuh yang tidak berfungsi membuat tubuh sensitif terhadap kanker. (Balingkalia, 2020).

Pada stadium dini, biasanya kanker tidak menunjukkan gejala. Gejala kanker biasanya timbul ketika kanker bermetamorfosis lebih cepat keorgan-organ di sekitarnya.

Tanda dan gejala yang sering kelihatan dan dirasakan pasien, yaitu:

- 1) Ada Massa di permukaan kulit
- 2) Perdarahan banyak dan sering, contoh menstruasi tidak sesuai dengan siklus menstruasi dan batuk darah
- 3) Sering mengeluh nyeri dan tidak sembuh meski telah diobati
- 4) Demam
- 5) Tidak teratur BAB/BAK
- 6) Kulit pucat
- 7) BB menurun secara dratis

Penatalaksanaan kanker yaitu kemoterapi, radiasi serta pembedahan, tindakan tersebut menyebabkan pasien mual dan muntah. Pasien menunjukkan perubahan fisik selama proses pengobatan kanker. Jika status gizi cukup dapat mencegah terjadinya masalah baru dari tindakan kemoterapi dan pasien memiliki stamina yang baik. Manajemen gizi adalah hal unsur yang esensial dalam mendukung pengobatan pasien (Balingkalia, 2020).

Tindakan manajemen penyakit kanker yang mempengaruhi status gizi yakni:

1) Kemoterapi

Kemoterapi berkontribusi menyebabkan gangguan sistem pencernaan di antaranya ialah: mual, stomatitis, gangguan sistem pencernaan dan nafsu makan menurun. Hal tersebut memberikan kontra indikasi terkait dengan takaran, waktu pengobatan, jenis obat dan reaksi pasien.

2) Radioterapi

Radioterapi juga menyebabkan gangguan pencernaan pada pasien. Fatalnya defisit nutrisi ditetapkan oleh lokasi dilaksanakan radioterapi, takaran dan waktu radioterapi.

3) Pembedahan

Pembedahan ialah pengobatan primer pada pasien kanker pada sistem pencernaan dapat

pengabungan pengobatan kemoterapi atau radioterapi.

4) Transplantasi sumsum tulang

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa asupan nutrisi pada sayuran dan buah segar melindungi pasien dari komplikasi. Mengingat pentingnya komposisi zat gizi makro dan zat gizi mikro yang sangat membantu tubuh untuk menjadi bergizi dan menghambat penyebaran kanker (Balingkalia, 2020)

C. Pencegahan Penyakit Tidak Menular

Peningkatan global penyakit tidak menular mempengaruhi stabilitas ekonomi dan keamanan/ketahanan manusia (*Human security*), maka dibutuhkan upaya mencegah PTM. Bentuk upaya preventif PTM yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Pencegahan tingkat awal (*primordial prevention*)

Mencegah munculnya faktor resiko terjadinya PTM dan mengurangi munculnya gejala melalui edukasi, promosi kesehatan. Misalnya: Menciptakan pola makan yang sehat dan bergizi “isi piringku”

2. Pencegahan tingkat pertama (*primary prevention*)

Usaha untuk mencegah terjadinya penyakit melalui usaha mengontrol faktor resiko dan meningkatkan lingkungan yang sehat melalui promosi kesehatan. Misalnya “GERMAS Pola Hidup Sehat” dengan tidak mengonsumsi makanan berkolesterol tinggi, tidak

merokok, menghindari stress, dan olah raga (berjalan kaki, atau jogging).

3. Pencegahan tingkat kedua (*secondary prevention*)

Diberikan kepada seseorang yang baru terdiagnosis penyakit atau terancam akan terserang penyakit tertentu melalui deteksi dini untuk menengakkan diagnosis dan memberikan pengobatan yang cepat tepat. Tujuan tindakan ini adalah discontinue penyakit lebih berat dan mencegah kecacatan. Misalnya mengontrol hipertensi, mengontrol kadar glukosa dan IMT secara berkala, dan menghindari terpapar dengan zat karsinogenik/zat berbahaya lainnya.

4. Pencegahan tingkat tiga (*tertiary prevention*)

Dilakukan kepada pasien penyakit tidak menular (DM, Hypertensi, Kanker, stroke dan lain-lain) serta mencegah terjadinya kecacatan maupun kematian. Misalnya patuh minum obat, cek kesehatan secara rutin di pelayanan kesehatan, dan pengobatan (kemoterapi atau pembedahan).

5. Rehabilitasi (*rehabilitation*)

Usaha untuk mengembalikan kondisi fisik, psikologis dan sosial semaksimal mungkin melalui pemulihan fisik, psikologis dan sosial.

D. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

PTM merupakan gangguan kesehatan secara garis besar di dunia termasuk di Indonesia. BPJS kesehatan menghabiskan

cukup tinggi pembiayaan pengobatan untuk pasien penyakit tidak menular. Meningkatnya kasus PTM di Indonesia memerlukan strategi tata kelola pencegahan dan pengendalian secara sistematis. Pengendalian PTM memerlukan dukungan dari berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, pertanian, perekonomian, perhubungan dan perencanaan lain yang dinilai kompeten untuk mengintervensi dampak PTM.

Prioritas primer strategi pencegahan dan pengendalian PTM ialah promosi kesehatan, preventif, dan kuratif, lebih menekankan pada upaya promotif, preventif dan skrining faktor risiko berbasis bukti (Risesda). Pemerintah melalui direktorat P2PTM Kementerian Kesehatan Republik Indonesia membuat rencana aksi kerja kegiatan tahun 2021-2024. Pembangunan kesehatan nasional tahun 2021-2024 yang bertujuan pencegahan dan pengendalian PTM meningkatkannya kesadaran masyarakat, keinginan, keterampilan untuk mencegah faktor resiko, melakukan skrining dan deteksi dini PTM bagi setiap individu agar tercapainya derajat kesehatan setinggi-tingginya 100% di seluruh Indonesia.

Arah kebijakan pencegahan dan strategi pencegahan dan pengendalian PTM difokuskan pada lima hal penting yaitu:

1. Penguatan deteksi dini dan faktor risiko PTM
Penguatan tersebut di titik beratkan kepada Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan pertama dimasyarakat. Deteksi

dini faktor risiko dilakukan melalui Posbindu. program tersebut meliputi pemeriksaan dasar, wawancara perilaku berisiko dan pendidikan kesehatan.

2. Penguatan kapasitas dan pengembangan sumber daya manusia

Pendekatan yang sesuai untuk mengembangkan kemampuan SDM melalui pelatihan yang intensif kepada kader terkait penyakit tidak menular dari tenaga kesehatan, menambah kegiatan kesehatan di masyarakat untuk menumbuhkan motivasi memanfaatkan Posbindu dan kerjasama lintas sektoral untuk penguatan program Posbindu

3. Penguatan sinergisme, kalaborasi dan intergrasi program

Memperbaiki mutu pelayanan melalui penguatan pelayanan kesehatan primer sebagai pintu terdepan, sistem rujukan, menyediakan perawatan lebih lanjut serta meningkatkan gerakan multisektoral terkait GERMAS.

4. Perluasan pemanfaatan teknologi tepat guna

Pelayanan kesehatan terdiri dari perluasan sistem rujukan online dan memperluas pengembangan jenis layanan kesehatan online. Sistem informasi untuk meningkatkan pelaksanaan kesehatan melalui aplikasi keluarga sehat (KS) dan aplikasi jamiinan keesehatan nasional (JKN).

5. Promosi kesehatan dan penurunan faktor risiko

Promosi kesehatan dan penurunan faktor risikomerupakan hal yang pentiing dalam preventif dan penanggulangan PTM. Promosi sangat penting untuk mendorong melakukan perilaku hidup sehat seperti makan makanan yang sehat, rendah garam dan rendah lemak, rajin olahraga, berhenti merokok dan mengelola stress. Perubahan gaya hidup dapat menurun risiko terjadinya penyakit tidak menuar.

Strategi pengendalian PTM menurut direktorat P2PTM Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu:

1. Upaya Layanan Berhenti Merokok (UBM)
Upaya layanan berhenti merokok di dilaksanakan oleh Puskesmas dan sekolah yang bertujuan menolong individu, kelompok dan komunitas berhenti merokok dan memberantas putus nikotin melalui konseling dan penyuluhan kesehatan.
2. Penerapan kawasan tanpa rokok di sekolah
Aplikasi kawasan tanpa rokok yaitu kawasan dinyatakan dilarang merokok, iklan rokok dan penyimpanan rokok yang bertujuan melindungi kawula muda dari perokok aktif dan perokok pasif, dan mengurangi jumlah perokok aktif di kelompok pelajar dan mengatasi masalah rokok pada pelajar.
3. Deteksi dini faktor risiko PTM di Posbindu
Posbindu PTM ialah bentuk partisipasi masyarakat untuk melakukan skrining dan penemuan kasus ssedini mungkin. Pelayanan yang diberikan dapat berupa

mengidentifikasi riwayat penyakit dalam keluarga, perilaku berisiko, penimbangan BB, mengukur TB, lingkar perut, IMT, mengukur tekanan darah, tes fungsi paru sederhana dan pendidikan kesehatan mengenai pemeriksaan payudara sendiri (SADARI).

4. Program Gerakan Nusantara Tekan Angka Obesitas (GENTAS)

Suatu aksi yang menyertakan masyarakat dalam upaya mencegah dan mengendalikan obesitas sebagai faktor risiko PTM di masyarakat. Pesan utama kegiatan ini atur pola makan dengan menggunakan prinsip makan model T, aktif bergerak melalui latihan fisik secara rutin, dan nikmati harimu melalui aktivitas yang liburan bersama keluarga, mengembangkan hobi, dan lain - lain.

5. Program Pelayanan Terpadu (PANDU) PTM

Usaha untuk mencegah dan menanggulangi PTM dengan meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam mendeteksi dini, memantau, dan menanggulangi PTM, sehingga morbiditas PTM menurun.

6. Program deteksi dini kanker pada wanita usia 30-50 tahun

Pemeriksaan payudara Klinis (SADANIS), dan pemeriksaan Visual asam asetat (IVA).

7. Program pengendalian thalasemia

Talasemia ialah penyakit keturunan (genetik) akibat kelaianan darah merah. Sampai saat ini penyakit talasemia tidak dapat disembuhkan akan tetapi dapat

dicegah dengan melakukan skrining pada pasangan yang mau merencanakan kehamilan.

8. Program deteksi dini dan rujukan kasus katarak
9. Program layanan kesehatan inklusi disabilitas
10. Program pengendalian penyakit kronis melalui CERDIK

E. Kesimpulan

PTM menjadi populer di setiap negara, penyebab kematian yang cukup tinggi, menghabiskan biaya yang cukup tinggi, defisit kemampuan sumber daya manusia, melemahnya potensi yang berdampak perekonomian suatu bangsa. Penyakit ini merupakan penyakit kronis, yang dapat diakibatkan oleh perilaku berisiko seperti konsumsi makanan instan yang kurang memperhatikan kualitas makanan, kurang olah raga, merokok, mengkonsumsi alkohol, dan stress.

Pengetahuan tenaga kesehatan sangat penting untuk melakukan perawatan yang intensif yang ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok dan komunitas. Upaya penanggulangan penyakit tidak menular sangat perlu dilakukan melalui lintas sektoral dan berfokus pada upaya promotif, preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. Tenaga kesehatan pada setiap tatanan pelayanan kesehatan perlu mengetahui upaya pengendalian dan pencegahan penyakit tidak menular sehingga dapat dicapai keberhasilan yang optimal.

Referensi

- Aisyah, R., Mahmudah, N., Candrasari, A., Sintowati, R., Bestari, R. S., Rosyidah, D. U., ... & Utami, I. (2024) "Improving Health Profiles and Type 2 Diabetes Mellitus Knowledge of Community Groups in Karanglo Village, Grogol, Sukoharjo, Central Java, Indonesia Through the SEE Method.," *Pengabdian kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement)*, 10, hal. 196-203.
- Alwa, M., Syafriani, S., & Lasepa, W. (2024) "Hubungan Obesitas Sentral, Asupan Natrium dan Lemak dengan Kejadian Hipertensi pada Dewasa di Desa Naumbai.," *indonesia of science*, 1.
- B, H., Akbar, K., & dkk. (2021) *Pencegahan Penyakit Tidak Menular Melalui Edukasi Cerdik Pada Masyarakat Desa Moyag Kotamobagu*.
- Balingkalia (2020) *Kanker pentingnya mengenal kanker lebih dekat*.
- Daulay, N. M., Siregar, N. D., Sujoko, E., Simamora, F. A., & Harahap, N. (2023) "FAKTOR FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN STROKE DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2022.," *Kesehatan Ilmiah Indonesia (Indonesian Health Scientific Journal)*, 8, hal. 106–116.
- Hanifah, W., Wanda, O. S., & Nisa, H. (2020) *Penelitian gizi dan makanan. Nutrition and Food Research*.

- Hasanah, N. (tanpa tanggal) *HUBUNGAN TINGKAT STRES, STATUS GIZI, DAN KEBIASAAN KONSUMSI JUNK FOOD DENGAN TEKanan DARAH PADA REMAJA DI SMA NEGERI 1 UNGARAN SKRIPSI.*
- Husna, D. S., & Puspita, I.D. (2020) "Jurnal Riset Gizi,," *Jurnal Riset Gizi*, 1, hal. 76–84.
- Kesehatan, J. I., Emilia, M., & Alpiah, D.N. (2024) *Pengaruh Komunikasi Terapeutik Pada Penderita Kanker : Literatur Review. Medic Nutricia.*
- Marliana, H.M. (2021) *LITERATURE REVIEW: ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN STROKE DI INDONESIA.*
- Nies, M. A., & McEwen, M. (2019) "keperawatan kesehatan komunitas dan keluarga."
- Nurdin, A., & Rahayu, D. (2024) "PERAN PROMKES DENGAN TINGGINYA PENYAKIT TIDAK MENULAR DI INDONESIA,," 1.
- Parums, D. V. (2023) "Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2023 Guidelines for COPD, Including COVID-19, Climate Change, and Air Pollution," *of Experimental and Clinical Research*, hal. e942672-1.
- Rahayu, D., & dkk (2021) *DETEKSI DINI PENYAKIT TIDAK MENULAR PADA LANSIA. JURNAL PEDULI MASYARAKAT.*
- Rikesdas. (2018) *Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar.*
- Rosaria, Susilowati dan Septimar (2024) "Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Tingkat Kecemasan Pada Pasien Kanker Yang Menjalani Kemoterapi Di RS Kanker

- Dharmais Tahun 2022 Lidia," *Termometer: Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan dan Kedokteran*, 2(1), hal. 136–151.
- Sung, H. *et al.* (2021) "Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries," *CA: A Cancer Journal for Clinicians*, 71(3), hal. 209–249.
- Tanrewali, M. S., & Wahyuningsih, W. (2019) "Pengalaman Pengobatan Dan Kecemasan Pada Pasien Kanker Di Awal Bros Hospital Makassar," *Of Health, Education And Literacy*, 2, hal. 14–18.
- Tanty, H. N., Fidia, F., & Meryta, A. (2024) "Edukasi Tatalaksana Diabetes Melitus Tipe II Di Kelurahan Duren Sawit Jakarta Timur.," *Pengabdian IKIFA*, 2, hal. 22–28.
- Tifany, E. P., & Tambunan, T.F.U. (2023) *Telerehabilitasi pada Penyakit Paru Obstruktif Kronik. Cermin Dunia Kedokteran.*
- Tjondronegoro, A., Azizah, A. M. N., & Claudia, V.O. (2023) *ANALISIS KEJADIAN STRESS ULCER PADA PASIEN STROKE SEBAGAI PREDIKTOR ANGKA MORTALITAS.*
- WHO. Int (2023) "Peyakit Tidak Menular."

Glosarium

BRCA1	= BReast CAncer1
BRCA2	= BReast CAncer2
CERDIK	= Cek kesehatan secara berkala, Enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat dengan kalori seimbang, istirahat yang cukup dan kelola stress
DM	= Diabetes mellitus
Emboli	= Gelembung udara.
FPG	= fasting plasma glucose
GENTAS	= Gerakan Nusantara Tekan Angka Obesitas
HBA1c	= Hemoglobin A1c
Hiperglikemia	= Kadar gula darah tinggi (> 120 mg/dl)
Hipoglimea	= Kadar gula darah rendah (< 70 mg/dl)
IMA	= Infark Miokard Akut
IVA	= Inspeksi Visual
IDDM	= <i>Insulin-Dependent Diabetes Mellitus</i>
KAD	= ketonacidosis diabetes
Multikausal	= Banyak penyebab
NIDDM	= <i>Non-Insulin-Dependent Diabetes Mellitus</i>
OGTT	= Glukosa Oral Toleransi Tes
Ovarium	= Rahim
PTM	= Penyakit Tidak Menular
PPOK	= Penyakit Paru Obstruksi Kronis
PJK	= Penyakit Jantung Koroner
PANDU	= Pelayanan Terpadu
SADANIS	= Pemeriksaan payudara Klinis
SKA	= Sindrom Koroner Akut

Spasme Vaskular	= kontraksi pembuluh darah
Trombus	= Gumpalan darah yang terbentuk di dinding pembuluh darah.
UBM	= Upaya Berhenti Merokok

BAB 3

Peran Keperawatan Komunitas Dalam Pemulihan Kesehatan Pasca Bencana

Dr. Faisal Ibnu, S.Pd., S.Kep.Ns., M.Kes.

A. Pendahuluan

Bencana, baik yang bersifat alami maupun buatan manusia, memiliki dampak besar terhadap kesehatan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, tren bencana menunjukkan peningkatan frekuensi dan intensitas akibat perubahan iklim, urbanisasi yang tidak terencana, dan konflik sosial. Peristiwa seperti gempa bumi Turki-Suriah 2023, banjir besar di Pakistan, serta pandemi COVID-19 memberikan gambaran nyata tentang bagaimana bencana dapat melumpuhkan sistem kesehatan dan kehidupan masyarakat (WHO, 2021; IPCC, 2022).

Kondisi pasca bencana sering kali ditandai dengan kerusakan infrastruktur vital, meningkatnya risiko penyebaran penyakit menular, kelangkaan sumber daya medis, serta trauma psikologis pada individu dan komunitas. Dalam situasi ini, perawat menjadi pilar utama dalam memberikan layanan kesehatan darurat dan berperan sebagai penghubung antara korban, tim kesehatan, dan pemerintah.

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Indonesia menghadapi lebih dari 2.500 bencana setiap tahunnya, termasuk gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Fakta ini, dikombinasikan dengan lokasi geografis Indonesia di "Cincin Api Pasifik," menempatkan negara ini pada risiko tinggi untuk berbagai jenis bencana. Dalam konteks ini, keberadaan perawat yang terlatih dan siap menghadapi situasi darurat menjadi sangat krusial untuk meminimalkan dampak negatif bencana terhadap kesehatan masyarakat.

B. Manajemen Bencana

Bencana merupakan serangkaian peristiwa yang mengancam serta mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor non alam ataupun factor manusia sehingga akan mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis pada korban bencana (UUD, 2007). Dalam menghadapi bencana, seorang

perawat harus dibekali dengan pengetahuan, keterampilan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Keterlibatan instansi di tingkat kerja dan pendidikan sangat penting untuk membentuk kesiapsiagaan perawat dalam menghadapi bencana. Pelatihan terkait kebencanaan sangatlah penting untuk meningkatkan kompetensi seorang perawat serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya (Ihsan, et al., 2022).

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat nasional dengan didukung kementerian/Lembaga terkait, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, TNI, Polri, Badan Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), dan kementerian/lembaga terkait lain. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi, kabupaten dan kota merupakan penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat daerah dengan didukung Organisasi Perangkat Daerah (OPd) terkait. Dalam masa tanggap darurat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat akan membentuk Pos

Komando (Posko) Tanggap Darurat, yang bertugas untuk melakukan upaya penanganan darurat (BNPB, 2017).

Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2007, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dibagi menjadi 3 tahap, meliputi:

1. Tahap Pra Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana dapat berupa:

- a. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi, pengurangan risiko bencana, pencegahan, pemanduan dalam perencanaan pembangunan, persyaratan analisis risiko bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, pendidikan dan pelatihan, persyaratan teknis penanggulanagan bencana.
- b. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan potensi terjadinya bencana.
 - 1) Kesiapsiagaan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan yaitu, penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;

pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini; penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar; pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat; penyiapan lokasi evakuasi; penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; serta penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

- 2) Peringatan dini dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat yang meliputi, pengamatan gejala bencana, analisis hasil pengamatan gejala bencana, pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang, penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana, dan pengambilan tindakan oleh masyarakat.
- 3) Mitigasi dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana dengan pelaksanaan penataan ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan, dan penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, serta

pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

2. Tahap Tanggap Darurat (Intra Bencana)

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dapat meliputi:

- a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya yang meliputi, cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan, serta kemampuan sumber daya alam maupun.
- b. Penentuan status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh BNPB dan BPBD mempunyai kemudahan akses yang meliputi, pengerahan sumber daya manusia, pengerahan peralatan, pengerahan logistic, imigrasi, cukai dan karantina, perizinan, pengadaan barang/jasa, pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang, penyelamatan, serta komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.
- c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan darurat, serta evakuasi korban.

- d. Pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi bantuan penyediaan, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, serta penampungan/ tempat hunian.
- e. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

3. Tahap Pasca Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi:

- a. Rehabilitasi, adapun kegiatan yang dapat dilakukan berupa perbaikan lingkungan daerah, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan social ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan dan keamanan, pemulihan fungsi pelayanan publik.
- b. Rekonstruksi, dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi pembangunan kembali prasarana dan sarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga

dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat, peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, peningkatan fungsi pelayanan publik, peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

C. Pemulihan Kesehatan

Pemulihan kesehatan merupakan pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh setelah terjadinya bencana dengan fase-fasenya yaitu:

1. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
2. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek

kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana (BPBD Provinsi NTB, 2025).

Pemulihan pasca bencana adalah upaya mengembalikan kondisi lingkungan dan masyarakat yang terdampak bencana. Pemulihan pasca bencana juga mencakup perbaikan dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan bencana. Kegiatan pemulihan pasca bencana meliputi:

1. Memfungsikan kembali sarana, prasarana, dan lembaga yang rusak
2. Memulihkan kondisi lingkungan yang rusak
3. Memulihkan kondisi fisik dan mental korban bencana
4. Memperbaiki dampak psikologis dan sosial korban bencana
5. Memberikan dukungan psikososial kepada korban bencana

Pemulihan pasca bencana merupakan salah satu fase dalam penanggulangan bencana, selain pencegahan dan kesiapsiagaan, serta penanganan kedaruratan.

D. Peran Keperawatan Komunitas dalam Pemulihan Kesehatan

1. Perawat Komunitas

Berdasarkan *Community Health Solution* (CHS, 1997), Keperawatan kesehatan komunitas adalah pelayanan keperawatan profesional yang ditujukan pada

masyarakat dengan penekanan kelompok risiko tinggi dalam upaya pencapaian derajat kesehatan yang optimal melalui peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pemeliharaan dan rehabilitasi dengan menjamin keterjangkauan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dan melibatkan klien (individu dan keluarga/komunitas) sebagai mitra dalam perencanaan pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan kesehatan.

Keperawatan kesehatan komunitas juga disebut perawatan kesehatan masyarakat (perkesmas), dan bekerja di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Keperawatan kesehatan komunitas (perkesmas) adalah salah satu bidang spesialis keperawatan yang melibatkan peran serta aktif masyarakat, dengan sistem pelayanan kesehatan yang berfokus pada upaya promotif, preventif secara berkesinambungan, tanpa mengabaikan pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif dengan menyeluruh dan terpadu (Nies & McEwen, 2015).

2. Tugas dan Peran Perawat Komunitas

Menurut Canadian Public Health Association (CPHA, 2010), terdapat peran yang dilakukan oleh perawat kesehatan komunitas yang meliputi, promosi kesehatan (health promotion), pencegahan penyakit dan luka (*desease and injury prevention*), perlindungan

kesehatan (*health protection*), pengawas kesehatan (*health surveillance*), pengkajian kesehatan populasi (*population health assessment*), kesiapsiagaan dan tanggap darurat (*emergency preparedness and response*).

a. Promosi kesehatan

Adapun peran perawat kesehatan komunitas terkait dengan promosi kesehatan sebagai berikut:

- 1) Mendorong adopsi terhadap keyakinan kesehatan, sikap, dan perilaku yang berkontribusi terhadap kesehatan populasi secara keseluruhan.
- 2) Mendukung adanya perubahan kebijakan kesehatan untuk memodifikasi fisik dan lingkungan sosial yang berkontribusi.
- 3) Membantu membangun, memelihara, dan/atau meningkatkan kesehatan baik pada masyarakat, keluarga, maupun individu melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan untuk memengaruhi determinan kesehatan.
- 4) Mendorong pengembangan kecakapan komunitas, keluarga, dan individu sehingga mereka dapat belajar untuk menyeimbangkan pilihan dengan tanggung jawab sosial dan pada akhirnya membuat sehat untuk semua.
- 5) Menginisiasi dan berpartisipasi dalam aktivitas promosi kesehatan dalam kemitraan dengan pihak lain.

b. Pencegahan penyakit dan luka

- 1) Menurunkan angka risiko wabah penyakit menular, termasuk identifikasi awal, investigasi, pelacaan kontak, langkah-langkah pencegahan, dan aktivitas untuk mempromosikan perilaku yang aman.
- 2) Mengontrol terjadinya penyebaran penyakit menular melalui teknik pencegahan, pengendalian penyakit menular, konseling perubahan perilaku, manajemen wabah, pengawasan, imunisasi, dan manajemen kasus.
- 3) Menggunakan strategi yang efektif untuk menurunkan factor resiko yang dapat berkontribusi terhadap penyakit kronis dan kecacatan.
- 4) Membantu masyarakat, keluarga, dan individu untuk berperilaku sehat yang mampu menurunkan kemungkinan terkena penyakit, luka, dan/atau kecacatan.
- 5) Mendorong terjadinya perubahan perilaku untuk meningkatkan derajat kesehatan di masyarakat.

c. Perlindungan kesehatan

- 1) Berkolaborasi dengan profesi kesehatan lain dan pemerintah, maupun lembaga lainnya untuk memastikan keamanan air, udara, dan makanan; mengontrol penularan penyakit; dan memberikan perlindungan dari ancaman lingkungan.

- 2) Mempertahankan lingkungan yang aman dengan bekerjasama bersama masyarakat, keluarga dan individu.
- d. Pengawas kesehatan
- 1) Mengintegrasikan eko-sosial surveillance dengan fokus yang lebih luas.
 - 2) Menelusuri dan meramalkan kejadian kesehatan atau determinan kesehatan melalui memobilisasi jaringan formal dan informal untuk mengumpulkan data secara sistematis dan rutin.
 - 3) Mengumpulkan dan menyimpan data dalam sistem yang bersifat rahasia.
- e. Pengkajian kesehatan populasi
- 1) Membuat sistem pelayanan baru melalui data pengawas kesehatan.
 - 2) Berkontribusi terhadap pengkajian komunitas dan termasuk sudut pandang masyarakat.
 - 3) Memainkan peran penting dalam memproduksi dan menggunakan pengetahuan tentang komunitas dan faktor yang mendukung kesehatan atau risiko potensial untuk menghasilkan kebijakan dan pelayanan yang lebih baik.

- f. Kesiapsiagaan dan tanggap darurat
- 1) Berpartisipasi dalam merespon keadaan darurat kesehatan masyarakat.
 - 2) Merencanakan dan mengevaluasi respons bencana alam (banjir, gempa bumi, kebakaran, ataupun wabah penyakit menular) dan bencana alam buatan manusia (ledakan, kimia, radioaktif, ataupun ancaman biologis) untuk meminimalkan penyakit yang serius, kematian, dan gangguan sosial.
 - 3) Mengomunikasikan secara detail tentang risiko sub kelompok populasi yang lebih berisiko tinggi dan mengintervensi atas nama mereka, selama kondisi darurat kesehatan masyarakat menggunakan saluran komunikasi yang beragam dan Teknik keterlibatan (Swarjana, 2016).

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 279 Tahun 2006 perawat minimal mempunyai enam peran dan fungsi, yaitu sebagai penemu kasus (*case finder*), sebagai pemberi pelayanan (*care giver*), sebagai pendidik/penyuluh kesehatan (*health teacher/educater*), sebagai koordinator dan kolaborator, pemberi nasehat (*counseling*), sebagai panutan (*role model*).

Selain itu berdasarkan penjelasan Widagdo (2016) mengenai peran perawat kesehatan komunitas yang meliputi:

a. *Manager Kasus*

Dalam hal ini, perawat kesehatan komunitas dituntut agar mampu mengelola pelayanan yang berkoordinasi dengan komunitas atau keluarga, penyedia pelayanan kesehatan atau pelayanan sosial yang ada. Adapun tindakan yang dapat dilakukan yaitu:

- 1) Mengidentifikasi kebutuhan komunitas terhadap pelayanan kesehatan. Hal ini penting dilakukan agar pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan komunitas.
- 2) Menyusun rencana asuhan keperawatan komunitas. Rencana ini dibuat berdasarkan hasil pengkajian kebutuhan komunitas terhadap pelayanan kesehatan.
- 3) Mengoordinasikan aktivitas tim kesehatan multidisiplin sehingga pelayanan yang diberikan dapat optimal dan tepat sasaran.
- 4) Menilai kualitas pelayanan keperawatan dan pelayanan kesehatan yang telah diberikan. Sebagai manager, hal ini penting untuk meningkatkan pengelolaan berikutnya.

b. Pelaksana Asuhan Keperawatan

Salah satu peran penting seorang perawat yaitu mampu melaksanakan asuhan keperawatan sesuai dengan kebutuhan keluarga dan komunitas. Adapun tindakan yang dapat dilakukan yaitu, melakukan pengkajian secara komprehensif, menetapkan masalah keperawatan komunitas, menyusun rencana keperawatan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi komunitas, melakukan tindakan keperawatan langsung mencakup tindakan mandiri (melakukan perawatan luka, melatih napas dalam dan batuk efektif, melatih latihan rentang gerak/ROM (*Range Of Motion*), serta tindakan kolaboratif (pemberian obat TBC dan sebagainya), mengevaluasi tindakan keperawatan yang sudah diberikan, mendokumentasikan semua tindakan keperawatan.

c. Pendidik

Perawat harus mampu menjadi penyedia informasi kesehatan dan mengajarkan keluarga atau komunitas tentang upaya kesehatan yang dapat dilakukan. Ada pun peran yang dapat dijalankan sebagai pendidik yaitu, mengidentifikasi kebutuhan belajar, yaitu apa yang ingin diketahui oleh komunitas, ini bias diketahui saat perawat melakukan pengkajian komunitas, memilih metode pembelajaran (ceramah, diskusi, atau demonstrasi),

dan materi yang sesuai dengan kebutuhan, menyusun rencana pendidikan kesehatan dan melaksanakan Pendidikan kesehatan, melatih komunitas/kelompok/keluarga tentang keterampilan yang harus dimiliki sesuai kebutuhannya, mendorong keluarga untuk melatih keterampilan yang sudah diajarkan perawat, serta melakukan dokumentasikan kegiatan Pendidikan kesehatan.

d. Pembela (*Advocate*)

Dalam menjalankan perannya sebagai pembela (*advocate*) perawat dapat melakukannya dengan mendukung pelayanan keperawatan yang berkualitas dan kompeten. Sikap perawat yang selalu berupaya meningkatkan kompetensinya agar asuhan keperawatan komunitas yang diberikan terjaga kualitasnya, merupakan contoh pelaksanaan peran sebagai pembela (*advocate*).

e. Konselor

Sebagai seorang konselor perawat membutuhkan keterampilan khusus seperti memahami (*expert*) di bidang keahliannya, dapat dipercaya untuk membantu komunitas atau keluarga dan mengembangkan coping yang konstruktif dalam penyelesaian masalah.

f. Penemu Kasus

Peran selanjutnya yang dapat dilakukan oleh perawat komunitas adalah melibatkan diri dalam penelusuran kasus di komunitas atau keluarga, untuk selanjutnya dilakukan kajian apa saja yang dibutuhkan komunitas.

g. Pembaharu

Peran perawat sebagai pembaharu berupa membantu komunitas untuk melakukan perubahan kearah kehidupan yang lebih sehat dengan cara:

- 1) Mengidentifikasi kekuatan dan penghambat perubahan. Hal ini penting dilakukan karena suatu perubahan merupakan suatu hal yang baru yang membutuhkan dukungan.
- 2) Membantu pencairan dan memotivasi untuk berubah.
- 3) Membantu komunitas menginternalisasi perubahan.

3. Peran dan Tugas Perawat Komunitas Dalam Penanggulangan Bencana

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Huriah & Farida, 2016), peran yang dapat dilakukan oleh perawat komunitas dalam upaya kesiapsiagaan yaitu, membuat, memperbaharui, dan mengimplementasikan *Disaster Plan*, melakukan pengkajian risiko pada komunitas seperti membuat peta bahaya dan analisis kerentanan,

melakukan tindakan pencegahan bencana seperti menumbuhkan kewaspadaan masyarakat dan sistem peringatan dini, memberikan penyuluhan dan simulasi persiapan menghadapi ancaman bencana kepada masyarakat, mengikuti program pelatihan penanganan bencana, dan memiliki *personal preparedness plan*, dan *family preparedness plan*.

Selain itu perawat kesehatan komunitas memiliki banyak peran selama bencana. Perawat kesehatan komunitas memiliki kemampuan untuk melayani sebagai manajer bencana, penyedia perawatan langsung, manajer pendidikan dan dukungan, komunikator risiko untuk kelompok populasi, dan sebagai konsultan untuk responden lain yang datang ke masyarakat untuk pertama kalinya (Powers & Elaine, 2010).

Tenaga perawat yang bekerja di rumah sakit dan puskesmas menempati posisi terbesar dibandingkan dengan tenaga kesehatan lainnya. Dalam jurnal manajemen bencana banyak kita temukan artikel terkait Disaster Nursing, dimana peran perawat dalam penanggulangan bencana tidak hanya mengurangi morbiditas dan mortalitas korban bencana pada saat respon darurat. Perawat berperan juga untuk mempersiapkan masyarakat siap menghadapi bencana dengan meningkatkan resilience. Menurut *International*

Council of Nurses (ICN) kompetensi perawat bencana muncul pada fase mitigasi, preparedness, relief, pemulihan dan rehabilitasi. Misalnya pada fase preparedness, perawat melakukan pengkajian kebutuhan komunitas, pada fase akut memberikan perawatan fisik dan mental bagi korban, pada fase pemulihan berperan untuk mengembalikan fungsi pelayanan kesehatan.

Informasi tentang kesiapsiagaan bencana oleh perawat di Indonesia khususnya berbasis masyarakat masih terbatas. Artikel berikut menarik, membahas tentang kesiapsiagaan bencana dalam kalangan koordinator perawat di Sulawesi Selatan Indonesia. Beberapa responden menganggap kesiapsiagaan bencana mereka masih lemah dan sedang. Sekitar sepertiga dari peserta menganggap latihan bencana sering sebagai metode pembelajaran terbaik untuk mencapai kesiapsiagaan bencana yang efektif (Bencana Kesehatan, 2014).

Peran perawat komunitas dalam pemulihan kesehatan pasca-bencana adalah meningkatkan kesiapsiagaan dan tanggung jawab dalam merespon bencana. Perawat komunitas juga dapat membantu meningkatkan sistem penanggulangan bencana pada fase pra-bencana, intra-bencana, dan pasca-bencana.

Adapun peran perawat dalam penanggulangan bencana secara umum adalah:

- a. Mengurangi morbiditas dan mortalitas korban bencana
- b. Mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi bencana
- c. Memindahkan korban dari daerah berbahaya ke tempat pengumpulan
- d. Memeriksa status kesehatan korban
- e. Memberikan pertolongan pertama
- f. Memindahkan korban ke pos medis lapangan

Pada fase pasca bencana, fokus utama adalah pemulihan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Perawat memainkan peran kunci sebagai tenaga kesehatan garis depan yang membantu individu, keluarga, dan komunitas pulih dari dampak bencana.

Beberapa peran utama perawat pada fase ini meliputi:

- a. Pemulihan Fisik Korban

Pada saat pemulihan fisik korban bencana maka perawat bertugas untuk:

- 1) Menyediakan pelayanan kesehatan primer, termasuk penanganan penyakit menular yang sering meningkat pasca bencana (misalnya, diare, demam berdarah, dan infeksi saluran pernapasan akut).

- 2) Melakukan tindak lanjut medis terhadap korban yang membutuhkan rehabilitasi, seperti pasien dengan luka serius atau yang menggunakan alat bantu mobilitas.
 - 3) Memberikan imunisasi untuk mencegah wabah penyakit yang sering terjadi pada kondisi darurat.
- b. Pendampingan Psikososial
- Trauma psikologis adalah dampak umum dari bencana. Peran perawat meliputi:
- 1) Memberikan dukungan psikososial melalui komunikasi empatik, konseling, dan terapi psikologis berbasis komunitas.
 - 2) Mengidentifikasi individu dengan gejala gangguan stres pasca trauma (PTSD) dan merujuk mereka ke spesialis kesehatan mental.
 - 3) Melibatkan komunitas dalam kegiatan yang memulihkan rasa normalitas, seperti program kelompok dukungan atau aktivitas rekreasi.
- c. Pemberdayaan Komunitas untuk Kesehatan Berkelanjutan
- Perawat berperan dalam memobilisasi masyarakat untuk membangun kembali ketahanan mereka:
- 1) Memberikan pendidikan kesehatan tentang sanitasi, kebersihan, dan pengelolaan lingkungan untuk mencegah penyebaran penyakit.
 - 2) Melatih masyarakat dalam manajemen risiko bencana dan kesiapsiagaan untuk mengurangi dampak di masa depan.

- 3) Bekerja sama dengan pemimpin komunitas dalam penyusunan rencana pemulihan berbasis komunitas.
- d. Koordinasi dengan Tim Multidisiplin
- Fase pemulihan membutuhkan sinergi antara berbagai pihak. Peran perawat meliputi:
- 1) Menjadi penghubung antara korban, organisasi kesehatan, dan pemerintah untuk memastikan kebutuhan kesehatan terpenuhi.
 - 2) Berpartisipasi dalam penyediaan layanan terpadu, termasuk distribusi logistik kesehatan dan pengelolaan shelter.
- e. Monitoring dan Evaluasi Pemulihan Kesehatan
- Perawat berkontribusi dalam memantau dan mengevaluasi proses pemulihan kesehatan melalui:
- 1) Pengumpulan data kesehatan masyarakat untuk mengidentifikasi tren penyakit dan risiko kesehatan.
 - 2) Melakukan survei kepuasan terhadap layanan kesehatan pasca bencana.
 - 3) Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan respons kesehatan dalam bencana mendatang.

4. Strategi Pemulihan Pasca Bencana

Rencana pemulihan harus berkualitas, disusun secara lengkap dan disempurnakan dari tahun ketahun. Semakin pendek masa pemulihan, maka semakin kecil kerugian akibat bencana. Begitu juga sebaliknya,

semakin panjang masa pemulihan, maka semakin lama mulainya kembali masa produktif. Dengan demikian pendek waktu pemulihan merupakan hal yang terpenting dalam masa pemulihan. Perpanjangan waktu pemulihan menjadikan perpanjangan masa tidak produktif. Kondisi fisik aset yang belum pulih akan mengganggu estetika (rasa keindahan), memelihara rasa gamang, duka-nestapa, yang menyebabkan semangat membangun terganggu bahkan berisiko menyebabkan kerusakan moral.

Strategi pemulihan pasca bencana telah dimulai sebelum bencana terjadi, menggunakan ancaman risk management untuk (1) risiko yang tak terduga dan (2) risiko yang diduga pasti akan terjadi dan tak dapat dielakkan. Bila bencana berskala besar, Presiden dapat mengangkat seorang Menteri Khusus untuk pemulihan bencana, untuk mengatasi masalah lintas departemen pemerintah dalam kurun waktu cukup lama. Manajemen Pemda bertanggungjawab menyusun *Disaster Recovery Plan (DRP)* paripurna, mengkomunikasikannya kepada DPRD. Semua persiapan *Disaster Recovery Plan (DRP)* dilakukan, dicadangan dan dialokasikan oleh APBD, sekalipun dalam usulan anggaran defisit.

Individu penanggungjawab bencana harus diidentifikasi secara jelas. Bagian peran tanggung jawab tiap individu dan kelembagaan harus jelas, jangan terjadi tumpang tindih. Tumpang tindih tugas kelembagaan antara Departemen Pemerintah Pusat untuk pemulihan bencana harus dibersihkan terus menerus oleh Presiden.

Pada *Disaster Recovery Planning*, probabilitas dan frekuensi bencana diidentifikasi dan diurutkan, lalu entitas menyusun antara lain:

- a. Daftar aset utama yang harus dijaga kelestariannya dibuat pada masa tenteram dan damai, sebelum bencana, disahkan sebagai basis perencanaan pemulihan bila terjadi bencana. Harga akuisisi aset baru atau replacement cost telah diketahui dan diperbarui-dimutakhirkan. Entitas membuat dana khusus untuk penggantian aset berisiko kena bencana yang tak dapat diasuransikan. Dengan demikian tak terjadi kegusaran perebutan sumberdaya pemulihan diantara stakeholder, yang pada umumnya minta diprioritaskan pada waktu bencana terjadi.
- b. Daftar aset utama/kritikal yang dapat diasuransikan, termasuk asuransi jiwa.
- c. Daftar aset yang dapat dihindarkan dari risiko bencana disusun, dan rencana kerja penghindaran

risiko dilaksanakan (relokasi, proteksi fisik dan lainnya).

d. Semua aset tersebut diatas, apabila rusak atau malafungsi menyebabkan entitas "lumpuh" "bangkrut" atau tak dapat beroperasi secara normal, harus mendapat prioritas perencanaan perlindungan dan penggantian serta merta:

- 1) Proteksi aset dan catatan/akuntansi aset.
- 2) Proteksi karyawan dan penduduk setempat disekitar aset.
- 3) Kesiambungan manajemen/pengelolaan.
- 4) Strategi memperpendek jangka waktu pemulihan.
- 5) Strategi pendanaan/pembiayaan pemulihan, antara lain pembentukan dana cadangan penggantian aset kena bencana.

Manajemen Pemda bertanggungjawab untuk menyusun *Disaster Recovery Plan (DRP)* paripurna dan mengkomunikasikannya kepada DPRD. Semua persiapan *DRP* dilakukan, dicadangkan dan dialokasikan pada APBD, sekalipun dalam rencana anggaran defisit. Orang atau Individu sebagai penanggungjawab bencana harus diidentifikasi secara jelas, pada umumnya para pejabat di wilayah administrasi keuangan dan akuntansi pemerintah daerah. Bagian peran serta tanggung jawab setiap individu dan kelembagaan harus jelas, jangan sampai terjadi tumpang tindih. Terutama tumpang tindih tugas

kelembagaan antara Departemen Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah (Pemda), sehingga proses pemulihan bencana dapat dilakukan secara terus menerus.

Manajemen, administrasi, akuntansi dan dokumentasi bencana dan pemulihan bencana pada tiap lembaga harus diatur secara tegas dan jelas, agar semua upaya dan sumberdaya yang diarahkan ke daerah bencana memenuhi syarat dan tidak terjadi tumpang tindih, efektif, ekonomis, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

E. Kesimpulan

Peran perawat komunitas dalam pemulihan kesehatan pasca-bencana adalah meningkatkan kesiapsiagaan dan tanggung jawab dalam merespon bencana. Perawat komunitas juga dapat membantu meningkatkan sistem penanggulangan bencana pada fase pra-bencana, intra-bencana, dan pasca-bencana. Peran utama perawat pada fase pasca bencana adalah pemulihan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Adapun fokus pemulihan kesehatan masyarakat antara lain:

1. Pemulihan Fisik Korban

Pada saat pemulihan fisik korban bencana perawat bertugas a) menyediakan pelayanan kesehatan primer, termasuk penanganan penyakit menular yang sering meningkat pasca bencana antara lain: diare, demam

berdarah, dan infeksi saluran pernapasan akut; b) melakukan tindak lanjut medis terhadap korban yang membutuhkan rehabilitasi, antara lain: pasien dengan luka serius atau yang menggunakan alat bantu mobilitas; c) memberikan imunisasi untuk mencegah wabah penyakit yang sering terjadi pada kondisi darurat.

2. Pendampingan Psikososial

Peran perawat meliputi: a) memberikan dukungan psikososial melalui komunikasi empatik, konseling, dan terapi psikologis berbasis komunitas; b) mengidentifikasi individu dengan gejala gangguan stres pasca trauma (PTSD) dan merujuk mereka ke spesialis kesehatan mental; c) melibatkan komunitas dalam kegiatan yang memulihkan rasa normalitas, seperti program kelompok dukungan atau aktivitas rekreasi.

3. Pemberdayaan Komunitas untuk Kesehatan Berkelanjutan

Perawat berperan dalam memobilisasi masyarakat untuk membangun kembali ketahanan mereka antara lain melalui: a) memberikan pendidikan kesehatan tentang sanitasi, kebersihan, dan pengelolaan lingkungan untuk mencegah penyebaran penyakit; b) melatih masyarakat dalam manajemen risiko bencana dan kesiapsiagaan untuk mengurangi dampak di masa depan; c) bekerja sama dengan pemimpin komunitas

dalam penyusunan rencana pemulihan berbasis komunitas.

4. Koordinasi dengan Tim Multidisiplin

Peran perawat meliputi: a) menjadi penghubung antara korban, organisasi kesehatan, dan pemerintah untuk memastikan kebutuhan kesehatan terpenuhi; b) berpartisipasi dalam penyediaan layanan terpadu, termasuk distribusi logistik kesehatan dan pengelolaan shelter.

5. Monitoring dan Evaluasi Pemulihan Kesehatan

Perawat memantau dan mengevaluasi proses pemulihan kesehatan melalui: a) pengumpulan data kesehatan masyarakat untuk mengidentifikasi tren penyakit dan risiko kesehatan; b) melakukan survei kepuasan terhadap layanan kesehatan pasca bencana; c) memberikan rekomendasi untuk meningkatkan respons kesehatan dalam bencana mendatang.

Referensi

- Australian Journal of Emergency Management. (2020). Post-disaster community health recovery: A nursing perspective. Retrieved from <https://knowledge.aidr.org.au>
- BNPB. (2023). *Laporan tahunan penanggulangan bencana di Indonesia*. Jakarta: BNPB.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2019). Data informasi bencana Indonesia. Retrieved from <https://bnpb.cloud/dibi/>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2016). Definisi bencana. Retrieved from <https://bnpb.go.id/home/definisi>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2014). Rencana nasional penanggulangan bencana 2015-2019. Retrieved from <https://bnpb.go.id/uploads/24/buku-renas-pb.pdf>.
- Carlson, S. J., & Parker, D. J. (1998). Disaster recovery planning and accounting information systems. Review of Business, Winter 1998.
- Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED) & United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR). (2019). Disasters 2018: Year in review. Retrieved from <https://www.emdat.be/publications>.
- Hamarno, R. (2016). Keperawatan kegawatdaruratan dan manajemen bencana. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

- Hammad, K. S., & Arbon, P. (2019). Nursing in the disaster recovery phase: A literature review. *International Journal of Nursing Practice*, 25(1), e12716. <https://doi.org/10.1111/ijn.12716>.
- Hariyanto, H. (2018). Thematic analysis sebagai metode menganalisa data untuk penelitian kualitatif. *Anuva*, 2(3), 317–324. Retrieved from <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/anuva>.
- Hewitt, K. (2014). *Regions of risk: A geographical introduction to disasters*. Routledge.
- Hoesada, J. (2010). Center for Risk Management Studies (CRMS). PT Cipta Raya Mekar Sahitya. CRMS Indonesia.
- Huriah, T., & Farida, L. N. (2016). Gambaran kesiapsiagaan perawat puskesmas dalam manajemen bencana di Puskesmas Kasihan I Bantul Yogyakarta. *Mutiawa Medika*, 10, 128–134.
- International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC). (2018). *Psychosocial support in emergencies*. Retrieved from <https://pscentre.org>.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 (pp. 1–21).
- Kementerian Pekerjaan Umum. (2012). Pedoman penyusunan sistem peringatan dini dan evakuasi untuk banjir bandang. Retrieved from https://www.jica.go.jp/project/indonesian/indonesia/0800040/materials/pdf/outputs_12_01.pdf.

- Kozier, B., Erb, G., Berman, A., & Snyder, S. J. (2016). Buku ajar fundamental keperawatan: Konsep, proses, & praktik (Vol. 1, 7th ed.). Jakarta: EGC.
- Li, Y. H., Chen, S. H., Xie, X. P., Song, Y. Q., & Jin, Z. H. (2016). Disaster nursing experiences of Chinese nurses responding to the Sichuan Ya'an earthquake. *International Nursing Review*, 16(1), 1–9. <https://doi.org/10.1111/inr.12316>
- Mulyanto, H., Parikesit, N. A., & Utomo, H. (2012). Petunjuk tindakan dan sistem mitigasi banjir bandang. Semarang. Retrieved from https://www.jica.go.jp/project/indonesian/indonesia/0800040/materials/pdf/outputs_15.pdf
- Munandar, A., & Wardaningsih, S. (2018). Kesiapsiagaan perawat dalam penatalaksanaan aspek psikologis akibat bencana alam: A literature review. *Nursing Provisions in Psychological Aspect Management of Natural Disasters: A Literature Review*, 9, 72–81.
- Nies, M. A., & McEwen, M. (2015). Keperawatan kesehatan komunitas dan keluarga. Singapore: Elsevier.
- Powers, R., & Daily, E. (Eds.). (2010). International disaster nursing. New York: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511841415>
- Swarjana, I. K. (2016). Keperawatan kesehatan komunitas. Bali: ANDI OFFSET.
- Toigo, J. W. (1989). Disaster recovery planning: Managing risk & catastrophe in information systems. Yourdon Press Computing Series. Prentice Hall.

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. (2007). Sistem penanggulangan bencana.
- Veenema, T. G. (2018). *Disaster nursing and emergency preparedness for chemical, biological, and radiological terrorism and other hazards* (4th ed.). Springer Publishing Company.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. (2007). Sistem penanggulangan bencana.
- Wiarso, G. (2017). Tanggap darurat bencana alam. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Widagdo, W. (2016). Keperawatan keluarga dan komunitas. Jakarta Selatan: Pusdik SDM Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Retrieved from <http://bppsdmk.kemkes.go.id/pusdiksdmk/wp-content/uploads/2017/08/Keperawatan-Keluarga-dan-Komunitas-Komprehensif.pdf>.

Glosarium

APBD = Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BASARNAS = Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
BMKG = Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
BNPB = Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBD = Badan Penanggulangan Bencana Daerah
CRMS = Center for Risk Management Studies
DRP = Disaster Recovery Plan
ICN = International Council of Nurses
OPD = Organisasi Perangkat Daerah
Pemda = Pemerintah Daerah
Posko = Pos Komando
PVMBG = Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
ROM = Range Of Motion

Profil Penulis



Septi Ardianty lahir di Palembang Sumatera Selatan Tanggal 13 September 1982, Riwayat pendidikan lulus SPK (Sekolah Perawat Kesehatan) DepKes Palembang tahun 2000, menyelesaikan sarjana Keperawatan dan Profesi Ners STIK Bina Husada Tahun (2006), selanjutnya lulus Magister Keperawatan Konsentrasi Keperawatan Komunitas di Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung (2014). Penulis memiliki pengalaman berkerja klinik sebagai staff perawat di Rumah sakit Saudi Arabi dari tahun 2007-2010, dan saat ini penulis berkerja sebagai dosen tetap di Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi (IKesT) Muhammadiyah Palembang sejak tahun 2010. Pengalaman mengajar penulis di Program Studi ilmu Keperawatan sebagai pengampuh mata kuliah keperawatan Komunitas, Keluarga dan gerontik di tahap akademik dan program profesi ners. Pengalaman organisasi saat ini sebagai ketua bidan pelayanan Komisariat PPNI STIKes Muhammadiyah Palembang dari tahun 2016 sampai dengan sekarang dan Sekretaris I Ikatan Persatuan Perawat Komunitas Indonesia (IPKKI) Wilayah Sumatera Selatan. Penulis juga memiliki kemampuan sebagai trainer dan terapis hypnoterapi tersertifikasi dari Lembaga IBH Center sejak tahun 2015. Penulis tetap berkomitmen meningkatkan kemampuan skill dan kemampuan dengan melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat, selain itu penulis juga aktif dalam menulis jurnal melalui hibah penelitian dan pengabdian masyarakat Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Palembang.

Profil Penulis



Lindawati Simorangkir, S.Kep, Ns, M.Kes. Lahir di Rantau Prapat, 15 Maret 1979. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Profesi, Sekolah Tinggi Ilmu Keseperawatan Sint Carolus Jakarta tahun 2005. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Sumatera Utara Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat dan lulus tahun 2012. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun **2007 – 2012 Seketaris program studi Ners STIKes Medistra Lubuk Pakam**. Saat ini penulis bekerja di STIKes Santa Elisabeth Medan mengampu mata kuliah Promosi Kesehatan, Keperawatan Komunitas, Keperawatan Keluarga, Keperawatan Gerontik dan K3. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku Ajar Keperawatan Komunitas, Modul Praktikum Keselamatan Pasien Dan Keselamatan Kesehatan Kerja Dalam Keperawatan, *Upaya Pengembangan Kemampuan Berpikir Kritis*. Penerbit NEM. *Mengenal lansia dalam lingkup keperawatan*. Yayasan Kita Menulis. Pendidikan Promosi Kesehatan masyarakat Bina Media publikasi internasional dan nasional. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: lindasimorangkir79@gmail.com

Profil Penulis



Dr. Faisal Ibnu, S.Pd., S.Kep., Ns., M.Kes.

Lahir di Lamongan, 15 Februari 1972. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu Program S1 Ilmu Pendidikan pada Universitas PGRI Adibuana Surabaya tahun 2002, Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Kesehatan pada Universitas Airlangga Surabaya lulus tahun 2006. Program S1 Keperawatan dan Profesi Ners lulus tahun 2011. Selanjutnya menempuh program Pendidikan Doktorat Keperawatan di Universitas Indonesia lulus tahun 2020. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1997- 1999 bekerja sebagai perawat pelaksana di RSUD Sidoarjo, selanjutnya per 1 Maret 1999 sampai sekarang bekerja di UBS PPNI Mojokerto. Saat ini penulis bekerja di Universitas Bina Sehat (UBS) PPNI Mojokerto mengampu mata kuliah Keperawatan Komunitas, Keluarga, Gerontik, Metodologi Penelitian dan Biostatistik. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi ilmiah, seminar, dan sebagai nara sumber di berbagai instansi. Penulis juga aktif di organisasi profesi sebagai Sekretaris DPD PPNI Kab. Mojokerto dan sebagai pengurus Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas Indonesia (IPKKI) Jawa Timur. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: faizubspgni@gmail.com

Motto: "Life is a choice, so do it with strong intentions and full of wisdom"

SINOPSIS

Buku "Keperawatan Komunitas dalam Menghadapi Masalah Kesehatan Masyarakat" mengangkat peran penting keperawatan komunitas dalam menjawab berbagai persoalan kesehatan yang berkembang di tengah masyarakat. Mulai dari isu kesehatan remaja, perubahan gaya hidup, hingga meningkatnya penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan kanker, buku ini memberikan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana pendekatan komunitas dapat menjadi solusi efektif.

Melalui pendekatan promotif, preventif, serta edukatif, buku ini menawarkan berbagai strategi dan intervensi praktis yang dapat diterapkan langsung di lapangan. Penjelasan yang disajikan dikemas secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memudahkan pembaca untuk mengaitkan teori dengan realitas sosial di masyarakat. Buku ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara tenaga kesehatan dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup bersama.

Ditujukan bagi mahasiswa, praktisi, dan semua pihak yang peduli pada kesehatan masyarakat, buku ini hadir sebagai referensi yang dapat memperluas wawasan sekaligus mendorong aksi nyata di lingkungan komunitas. Harapannya, buku ini dapat menjadi inspirasi dan sumber daya yang berguna dalam membangun masyarakat yang lebih sehat dan berdaya.

Buku "Keperawatan Komunitas dalam Menghadapi Masalah Kesehatan Masyarakat" mengangkat peran penting keperawatan komunitas dalam menjawab berbagai persoalan kesehatan yang berkembang di tengah masyarakat. Mulai dari isu kesehatan remaja, perubahan gaya hidup, hingga meningkatnya penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan kanker, buku ini memberikan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana pendekatan komunitas dapat menjadi solusi efektif.

Melalui pendekatan promotif, preventif, serta edukatif, buku ini menawarkan berbagai strategi dan intervensi praktis yang dapat diterapkan langsung di lapangan. Penjelasan yang disajikan dikemas secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memudahkan pembaca untuk mengaitkan teori dengan realitas sosial di masyarakat. Buku ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara tenaga kesehatan dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup bersama.

Ditujukan bagi mahasiswa, praktisi, dan semua pihak yang peduli pada kesehatan masyarakat, buku ini hadir sebagai referensi yang dapat memperluas wawasan sekaligus mendorong aksi nyata di lingkungan komunitas. Harapannya, buku ini dapat menjadi inspirasi dan sumber daya yang berguna dalam membangun masyarakat yang lebih sehat dan berdaya.



Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7219-27-5



9

786347

219275